

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 心臟科

- (A) 1. 有關心臟聽診(Cardiac auscultation)，請問下列何者說法是不正確的？
- A. 僧帽瓣閉鎖不全(Mitral regurgitation)、主動脈瓣閉鎖不全(Aortic regurgitation)及心室中隔缺損(Ventricular septal defect)等心臟雜音都可因血管擴張劑之靜液注射後而更加增強
 - B. 蹲坐(Squatting)可致肥厚性心肌病變所致心臟雜音更趨強
 - C. 從臥躺而站立後，二尖瓣脫垂(Prolapse of mitral valve)所致心縮期敲擊性心音(Systolic click)更趨近第一心音(S1)
 - D. 主動脈瓣狹窄(Aortic stenosis)的心縮期雜音常在蹲坐後心雜音更強化
 - E. 三尖瓣閉鎖不全的心雜音常在深吸氣時更加強化
- (A) 2. 有關冠心病的幾種說法，請問下列何者不是當今實證醫學的說法？
- A. 男性比女性較多因心血管病而死亡
 - B. 近數十年在男性因心血管而死亡人數已大幅度降低，但女性病亡人數卻不減反升
 - C. 冠心病之發生常與冠脈微循環(Coronary microcirculation)之異常有關，尤於女性病人最為嚴重
 - D. 女性較男性好發冠心病，研究顯示與肥胖、糖尿病、發炎及代謝症候群等冠心病危險因素之多發有關
 - E. 女性運動心電圖有較多的偽陽性缺氧變化，以致臨床診療常見誤診
- (C) 3. 77歲老太太一向健朗，未有任何不適症狀，因主動脈區有心縮性心雜音而轉診內科。理學檢查：Height: 160cm/ Weight: 55kg; BP:142/82 mmHg; T/P/R: 36.2 /60 /20, SpO2: 99% under room air; Pulsus paradoxicus (-), PMI: 5th ICS, around left mid-clavicular line, aortic ejection sound (+), Gr. III/VI Mid-systolic murmur over Aortic area and left lower sternal border, no neck radiation; Lungs: No crackles; No hepatosplenomegaly and no ascites; No legs edema. 其心電圖、胸部X光、心臟超音波及心導管報告如列。本病人隨即有下列諸項臨床決策：(1)初步診斷是高血壓及高血壓性心臟病(2)初步診斷是主動脈瓣狹窄心臟病(3)在現階段最好的內科治療是適量的Beta-blocker, Calcium channel blocker, ACE inhibitors or Angiotensin receptor blocker，以降低血壓(4)由於未有明顯的心絞痛、眩暈或呼吸困難，在現階段最恰當的治療是以Statin、Angiotensin receptor blocker及Beta-blocker為宜(5)內科及外科的治療，對其預後無有改進，本病人的唯一選擇是主動脈瓣膜置換手術或經導管主動脈瓣膜置放手術，請問下列何組決策是正確的？
- A. (1)+(3)+(5)

- B. (1)+(3)+(4)
- C. (2)+(3)+(5)
- D. (1)+(4)+(5)
- E. (2)+(4)+(5)

- (C) 4. 吳先生現年20歲，一向健壯，從事建築粗工，於3月22日有感冒流鼻水、發燒及咳嗽症狀，三天後更有全身倦怠及暈厥，乃至心疼，因心電圖及胸X光異常(如圖)，而從急診住院。理學檢查：Consciousness: drowsy, E3VTM4;T:37.5 P:93 R:16及BP:82/65 mmHg; 頸靜脈怒張; 胸部有濕濁呼吸音; 心臟未有擴大，心音略為微弱，尚無S3或S4及心臟雜音可聞; 腹部未有腹水或肝脾腫大; 雙腳未見水腫。實驗室檢查：WBC,8.37 K/uL;RBC,4.35 M/uL;Plt,128 K/uL; Hb, 13.0 gm/dL;CK,514 U/L;CK-MB,43 U/L; Troponin I, 2.6 ug/L; CRP, 5.6 mg/dL。本病人隨即進行下列臨床決策：
- (1) Continuous IV infusion of Dopamine at the dose of 7.8 mcg/kg/min，以穩定血壓及心跳及血氧
 - (2) 使用IV Heparin at the dose of 1000 u/hour，以預防血栓的形成
 - (3) 3月27日因持續性Ventricular tachycardia，採用 Electric cardioversion不盡有效，而置放V-A ECMO及IABP
 - (4) 3月28日進行Left ventricular assisted device，以維持左心室功能
 - (5) 3月29日Myocardial biopsy之病理確診後，使用IVIG，也使用Prednisolone、Cyclosporine及Azathioprine
 - (6) 病情在3月31日後於焉穩定 從診斷及處置，本病例的處置尚稱成功。請問下列何者才是Evidence-based management?
- A. 從病史、理學檢查及Troponin I 或CRP的數值可確定診斷
 - B. 從胸部X光及心電圖可確定診斷
 - C. 從病程血行力學之不穩定，應逕行Myocardial biopsy
 - D. 使用Immunosuppressive agents:Prednisolone及Cyclosporine是本例治療成功的重要因素
 - E. 使用IVIG(Intravenous immunoglobulin)才是救命的要訣
- (C) 5. 病人男性59歲於午夜24時，突因胸悶並有牙床緊疼，乃直往急診部求診，時病人之T/P/R = 35.1/51/18, BP 137/74 mmHg; 理學檢查，未見任何異常。病史追尋，本病人曾經醫師確定高血壓、高脂血、糖尿病及攝護腺肥大，唯僅只服用Bisoprolol 2.5 mg/day。經緊急檢查：其心電圖及胸部X光顯示如圖：生化檢查: CK,96 U/L;CK-MB,20 U/L;Tnl <0.0012 ng/ml;Sugar 252 mg/dL; Na,137 mmol/L; K, 3.7 mmol/L; TG,182 mg/dL and Total cholesterol, 222 mg/dL ; 血液檢查: Hb,13.9 g/dl; Platelet, 203 K/uL; WBC,9.45 K/uL; Cre,1.3 mg/dL 請問本病人最可能的急診診斷是：
- A. Prinzmetal's angina
 - B. Aortic dissection
 - C. Acute anterior myocardial infarction

- D. Hypertension
- E. Acute periodontitis disease

- (C) 6. 依據今年1月台灣心臟學會及高血壓學會所公告之高血壓處置指引 (2015 Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology and the Taiwan Hypertension Society for the Management of Hypertension)，請問下列何者說法是錯誤的？
- A. 台灣的高血壓處置指引與最近歐洲及美國的指引不盡相同
 - B. 80歲以上的老年人降壓以低於150/90 mmHg為治療目標
 - C. 糖尿病、冠心病、慢性腎病變併有蛋白尿病人之高血壓，以低於140/80 mmHg為治療目標
 - D. 服用抗血栓藥物防治腦中風發作之降壓目標，以不高於130/80 mmHg
 - E. 所有病人(40-80歲)之高血壓治療目標在140/90 mmHg以下
- (D) 7. 一向主導全世界高脂血處置之NCEP ATP III，於2013年11月公布新的指引，請問下列何項不是新的規定？
- A. 有冠心病、腦血管或週邊血管病之病人應服用Statin治療
 - B. 40-75歲的人只要LDL-C高於190 mg/dL應服用Statin治療
 - C. 40-75歲糖尿病人應服用Statin治療
 - D. 所有病人之血脂濃度：LDLC以低於100 mg/dL，而Cholesterol 180 mg/dL為治療目標
 - E. 只限定Statin一藥，排除Fibric acid 及Cholestyramine為降脂血藥物
- (B) 8. 臨床處置指引常依據實證修訂，有關感染性心內膜炎 (Infective endocarditis) 有下列諸多的記述：(1)血液細菌培養應在24小時內採血三次，在不同血管處採血，且應相隔至少一小時實施 (2)心臟超音波檢查是必要的診斷工具，經食道心臟超音波檢查適用於心肌膿腫、瓣膜破洞、心內瘻管及人工瓣膜心內脈炎的診斷 (3)二尖瓣脫垂病人接受牙科治療應作預防性抗生素使用 (4)有發紺先天性心臟病人、人工瓣膜置換手術後病人、曾有心內膜炎病史及換心人有主動脈瓣病變者應預防性抗生素使用 (5)病人裝置ICD(Intra-cardiac device) 接受大腸鏡檢查應預防性抗生素使用 請問下列何組是正確的處置指引？
- A. (1)+(2)+(3)
 - B. (1)+(2)+(4)
 - C. (1)+(3)+(5)
 - D. (2)+(3)+(4)
 - E. (2)+(3)+(5)

- (B) 9. 男性病人現年60歲，於清晨6時突然胸悶、冷汗，自覺伴有後背及腹部酸疼，病人由家屬急送醫院。病人有多年高血壓及痛風病，服用Losartan(50mg) 1tabQD; Amlodipine(5mg) 1tabQD; Colchicine(0.5mg) 1tabQD; Benzbromarone(100mg) 1tabQD; Atorvastatin 0.5 Tab /HS等藥中。身體檢查，呈現急病狀，臉色蒼白，體溫: 36.2°C，脈跳: 66/min，呼吸: 23/min；BP: 252/114mmHg；意識清楚；胸部及腹部尚無異常，心律正常，S1及S2正常，未有S3或S4，無心臟雜音可聞，也無paradoxical split of S2，神經檢查正常。其時實驗室檢查如圖表。下列何者是正確的診斷？
- A. Acute myocardial infarction
 - B. Aortic dissection
 - C. Hypertensive crisis
 - D. Pulmonary embolism
 - E. Aortic stenosis
- (D) 10. 女性病人現年47歲，G2P2，主訴近來一個月間時有頭昏，並有漸進式呼吸困難。住院前四天症狀更形惡化，是乃經急診住加護病房。理學所見: 身高163cm; 體重 67.4kg; BMI = 25.37; 體溫: 36.5°C ; BP(mmHg): 128/60; PR(/min): 104; RR(/min): 24; 臉血蒼白; 心跳快速但正常律動, 在三尖瓣區有Grade 3/6 systolic murmur可聞，其他尚無重大異常。其心電圖及胸部X光和Computer tomography如圖。D-Dimer, 3.56 mg/L; Blood gas: pH, 7.534; PaO₂, 57 mmHg; PaCO₂, 20.9 mmHg; HCO₃⁻ std 22.0 mmol/L; 病人住院後隨即靜注大方劑量(Bolus dose) Unfractionated Heparin 3000u 及每小時1000u靜脈輸注。病程中先後進行下列處置：(1)通知心臟科啟動PCI團隊 (2) 查Protein C，Protein S和anti-thrombin III, 和Anticardiolipin IgG (3) Tumor biomarkers : CEA, CA-199, CA-125, CA-153 (4) Heparin bolus 3000 unit IV stat and then IV pump 6~12 U/kg/hr according to the aPTT (5) Digoxin 0.25 mg + 20% glucose in water for IV to control tachycardia 請問下列何組處置才是正確的？
- A. (1)+(2)+(3)
 - B. (1)+(3)+(4)
 - C. (1)+(3)+(5)
 - D. (2)+(3)+(4)
 - E. (2)+(4)+(5)
- (D) 11. 病人是位47歲家庭主婦，自7歲起就診斷有心臟病，18歲懷孕生有一子，過程尚稱順利，近十年來偶有心悸及胸悶，近二年曾有五次昏厥，因此住院。理學檢查及生化檢驗都正常。胸X光及心電圖(如圖)。本病人最有可能的診斷是：
- A. Supraventricular tachycardia
 - B. WPW syndrome with AVRT
 - C. Long QT syndrome with Torsade de pointes

- D. Monomorphic ventricular tachycardia from outflow tract
- E. Polymorphic ventricular tachycardia with Torsade de pointes

- (B) 12. 38歲女性因為很容易出現運動喘而來檢查，下列哪一個身體檢查的發現最容易懷疑是否有肺動脈高壓？
- A. 頸靜脈鼓脹，心音S1，S2正常。在右上胸骨緣有 II/VI 等級的舒張期心雜音。
 - B. 頸靜脈鼓脹，大聲的S2心音。在左下胸骨緣有 II/VI等級的收縮期心雜音。
 - C. 頸靜脈鼓脹，大聲且固定而分裂的S2心音。在左下胸骨緣有 III/VI等級的收縮期心雜音。
 - D. 頸靜脈鼓脹，吐氣時S2心音分裂。在左上胸骨緣有 大聲而尖銳的II/VI等級的收縮期心雜音。
 - E. 頸靜脈鼓脹，桶型胸腔變形。呼吸週期的吐氣期特別長。
- (D) 13. 60歲女性因為逐漸出現的喘氣造成無法行走正常距離而到急診，他沒有胸痛、支氣管哮喘、痰或是發燒。胸部X光檢查發現雙側肺動脈擴張，左心房擴大，雙側肺部沒有浸潤現象。心電圖出現V1導極有高的R波，心軸右偏。此時幫患者進行心臟超音波檢查，最可能會出現下面哪一種變化？
- A. 主動脈瓣迴流
 - B. 主動脈瓣狹窄
 - C. 左心室收縮功能低下
 - D. 二尖脈（僧帽瓣）瓣狹窄
 - E. 二尖脈（僧帽瓣）瓣迴流
- (D) 14. 高血鉀的心電圖變化，請在下列項目中選擇最適合的發現：(1) P波變平而可能消失；(2) ST segment延長；(3) U波明顯變大；(4) QRS波變寬；(5) T波變高；(6) PR interval縮短
- A. (3)+(5)+(6)
 - B. (1)+(2)+(3)
 - C. (3)+(4)+(6)
 - D. (1)+(4)+(5)
 - E. (2)+(4)+(5)
- (D) 15. 所謂「完整的心臟病診斷」(Complete cardiac diagnosis)應依序包括哪些項目組合？
- A. 病因、病理、生化及功能異常(Functional disability)的診斷
 - B. 咳血生理、解剖、病理及功能異常的診斷
 - C. 病理、生理、功能及生化異常的診斷
 - D. 病因、解剖、生理及功能異常的診斷
 - E. 病因、病理、生理及功能異常的診斷

- (A) 16. 當心房纖維顫動出現，下列哪一些因子會加重患者的腦血管血栓事件的可能性？(1) 糖尿病；(2) 左心房4.2公分；(3) 曾經有暫時缺血性腦中風發作；(4) 高血脂；(5) 鬱血性心衰竭；(6) 年齡62歲
- A. (1)+(3)+(5)
B. (2)+(4)+(6)
C. (1)+(2)+(3)
D. (4)+(5)+(6)
E. (2)+(3)+(4)
- (B) 17. 門診時有位擔心的母親來向你詢問有關他兒子的問題，兒子在國一的新生入學檢查中發現有心房中隔缺損。關於如果沒有修復心房中隔缺損，在成年或多年之後，最不可能出現下列哪一種情況？
- A. 因為醫療目的而進行中心靜脈管置入術（CVC）而產生氣栓（Air emboli）
B. 不穩定性狹心症
C. 栓塞性腦血管事件
D. 肺高壓
E. 運動中氧動脈分壓隨之下降
- (C) 18. 42歲女性在成人健檢中發現有收縮中期異常心音- Mid-systolic click，沒有發現心雜音。除此之外的身體檢查正常，血液檢查項目數值正常，平日也沒有不舒服。她還是擔心相關的發現，依照上述情況，下列哪一相敘述較適當？
- A. 說明大多數的這類患者存有結締組織疾病，進行檢查
B. 解釋並告知病人針對感染性心內膜炎進行相關防範措施
C. 大部分此種發現會一直存在，但不需治療
D. 建議她使用Aspirin 100mg/day 來預防血栓事件
E. 這類問題無法從心臟超音波檢查，不要要求做超音波檢查
- (C) 19. 下列哪一些身體檢查的發現會懷疑嚴重的主動脈瓣迴流？
(1) Corrigan's pulse；(2) Pulsus bigeminus；(3) Quincke's pulse；(4) Traube's sign；(5) Pulsus parvus et tardus；(6) Pulsus paradoxus
- A. (2)+(4)+(6)
B. (1)+(2)+(3)
C. (1)+(3)+(4)
D. (3)+(5)+(6)
E. (4)+(5)+(6)
- (B) 20. 78歲男性，有長期吸菸，肥胖和十年左右的第二型糖尿病。他因為最近兩個月出現的運動喘前來門診。目前他使用的藥品包含 aspirin, metformin 和偶爾會因為關節疼痛服用 ibuprofen。他的身體檢查發現延遲出現-- 脈搏尖峰（delayed peak in peripheral pulse），left ventricular

heave。他的心跳規則，在心臟基底部位(cardiac base)有VI/VI 級的收縮期心雜音，此雜音會傳向頸動脈區域。同時出現第四心音，心臟超音波只有嚴重的主動脈瓣狹窄。請問依據病史與相關發現，造成這個病人心臟變化的最可能原因是？

- A. 先天性二瓣的主動脈瓣膜 (bicuspid aortic valve)
- B. 糖尿病
- C. 風濕性心臟病
- D. 病人有潛藏的結締組織疾病
- E. 以上皆非

- (E) 21. 當患者的心臟超音波檢查發現有嚴重的二尖瓣迴流，考量手術適應症，併發症與手術預後，下面哪一個敘述的患者會有最佳的術後進步和手術治療效果？
- A. 52歲男性，LVEF=25%，心衰竭症狀NYHA class III，左心室收縮末期內徑60mm。
 - B. 54歲男性，LVEF=30%，心衰竭症狀NYHA class II，有肺高壓。
 - C. 63歲男性，竇性規則心律，LVEF=65%，沒有臨床症狀，右心室導管檢查壓力正常。
 - D. 72歲女性，沒有臨床症狀，新發現陣發性心房纖維顫動，LVEF=60%，左心室收縮末期內徑35mm。
 - E. 66歲女性，LVEF=50%，沒有臨床症狀，左心室收縮末期內徑45mm。
- (D) 22. 30歲，BMI=23，在建築工地工作的男性高血壓患者，因為已經服用四種藥物之後仍出現180/110mmHg的血壓前來門診。依患者所說，他從17歲就發現有高血壓，雖然醫師在過去給他四種控制血壓的藥物，他並沒有覺得特別不舒服。平日不常量血壓，只在偶爾發現血壓很高時從藥房加買藥物服用。門診時身體檢查沒有異常，抽血的數據如下：Na: 145mEq/L; Cl: 110mEq/L; K: 3.0mEq/L; HCO₃: 30 mEq/L; Glucose: 90mg/dL。請問接下來如何處置較治當？
- A. 加第五種藥物，請患者密切追蹤血壓
 - B. 測量尿液中的VMA; metanephrines; catecholamines
 - C. 安排雙側腎動脈的都卜勒超音波檢查
 - D. 檢查 plasma renin activity (PRA) 與 plasma aldosterone concentration (PAC)
 - E. 安排睡眠醫學檢查

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 胸腔科

- (C) 1. 關於肺部聽診的敘述,下列何者正確? (1)哮鳴音(wheezes)代表氣道阻塞 (2)囉音(crackles)代表肺泡疾病 (3)肺間質纖維化(interstitial fibrosis)會出現egophony (4)肺實質化(consolidation)不會出現whispered pectoriloquy (5)肺氣腫(emphysema)可出現呼吸音降低
- A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(3)+(4)
C. (1)+(5)
D. (4)+(5)
E. (3)+(4)+(5)
- (B) 2. 關於氣喘階梯式治療(stepwise therapy)的敘述,下列何者正確? (1)每周使用緩解藥物(reliever medication)大於兩次以上,就需規律使用控制藥物(controller medication) (2)控制藥物的首選為吸入型類固醇(inhaled corticosteroids) (3)第一階段病人僅使用吸入型短效之乙型交感神經刺激就可以 (4)吸入型類固醇的起始劑量為中劑量(相當200 µg BID/day beclomethasone dipropionate) (5)使用控制藥物後兩個月就可評估治療效果
- A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(3)+(4)
C. (1)+(5)
D. (4)+(5)
E. (3)+(4)+(5)
- (C) 3. 關於特殊因子和社區性肺炎可能病原菌的組合,下列何者錯誤?
- A. Bronchiectasis--P.aeruginosa
B. 肺膿瘍--oral anaerobes
C. 流感(influenza)--Klebsiella pneumoniae
D. COPD--Haemophilus influenzae
E. 鳥類接觸--Chlamydia psittaci
- (C) 4. 關於呼吸器相關肺炎(ventilator-associated pneumonia)病理機轉和相關預防策略的組合,下列何者錯誤?
- A. 正常菌的減少(elimination of normal flora)--避免抗生素使用時間過長
B. 下呼吸道抵抗力改變(altered lower respiratory host defense)--降低輸血時血紅素的閾值(hemoglobin transfusion threshold)
C. 氣管內管周圍物質的吸入(microaspiration around endotracheal tube)--加強鎮靜
D. 呼吸器使用時間過長--呼吸器脫離流程(weaning protocols)
E. 胃食道逆流--prokinetic agents

- (C) 5. 關於造成肋膜積液(pleural effusion)的原因,下列何者是漏出液(transudate)?
- A. Meig's syndrome
 - B. ovarian hyperstimulation syndrome
 - C. myxedema
 - D. uremia
 - E. rheumatoid pleuritis
- (D) 6. 下列狀況最適合使用非侵襲性呼吸器(noninvasive ventilation)者為?
- A. 心跳停止
 - B. 嚴重腸胃道出血
 - C. 不穩定心絞痛
 - D. 慢性阻塞性肺病急性惡化
 - E. 上呼吸道阻塞
- (D) 7. 關於阻塞性睡眠呼吸中止症(obstructive sleep apnea)的敘述下列何者錯誤?
- A. 可增加心肌梗塞的危險
 - B. 可引起肝功能異常
 - C. 可造成胰島素抗性(insulin resistance)
 - D. 治療阻塞性睡眠呼吸中止症可改善中風病人的預後
 - E. 會增加麻醉風險
- (B) 8. 實行身體檢查時,於肺部聽診,發現呼吸音減少,扣診時為 dullness 者,最可能為下列何者?
- A. 氣胸(pneumothorax)
 - B. 肋膜積液(pleural effusion)
 - C. 大葉性肺炎(lobar pneumonia)
 - D. 肺氣腫(emphysema)
 - E. 縱膈氣腫(pneumomediastinum)
- (D) 9. 關於結核性肋膜炎(tuberculous pleuritis)的敘述,下列何者錯誤?
- A. 經常與primary TB 有關
 - B. 為淋巴球為主的滲出液(exudate)
 - C. 對結核菌蛋白(tuberculous protein) 的一種過敏反應(hypersensitivity reaction)
 - D. 肋膜積液為adenosine deaminase >40 IU/L或 interferon- γ <140pg/ml
 - E. 肋膜切片對診斷有幫助
- (D) 10. 關於肺炎嚴重度評估CURB-65的項目,下列何者錯誤?
- A. 年齡
 - B. 意識不清
 - C. BUN
 - D. CRP(C-reactive protein)

E. 呼吸次數

(B) 11. 關於氣喘的敘述,下列何者錯誤?

- A. 吸入型類固醇是治療的主要藥物
- B. 合併治療(ICS+LABA,inhaled corticosteroid+long acting beta adrenergic agonist)建議於step2 (含)以上之病人使用
- C. 抗白三烯素(antileukotrienes)可作為controller 藥物
- D. 急性惡化時可使用全身性類固醇(systemic steroid)
- E. 少部分嚴重病人可使用anti-IgE

(C) 12. 下列哪一個不是乙二型交感神經刺激劑的作用?

- A. 放鬆呼吸道的平滑肌
- B. 減緩咳嗽
- C. 抑制慢性發炎反應
- D. 增加呼吸道纖毛運動
- E. 增加呼吸道黏液分泌

(C) 13. 下列關於過敏性肺炎(hypersensitivity pneumonitis)臨床表徵的敘述何者不正確?

- A. 成因是當具有特異體質的人,吸入過敏有機性物質時所致
- B. 可能出現發冷、發熱
- C. 在接觸過敏原後的一到兩個小時內出現呼吸困難症狀
- D. 支氣管肺泡灌洗液中的CD4與CD8淋巴球細胞的比例常小於1
- E. 支氣管肺泡灌洗液中肥大細胞的量可能和疾病嚴重度成正比

(A 14. 下列何者是目前國際間做單肺肺臟移植最常見的適應症?

- or
- (C)
- A. 慢性阻塞性肺病(COPD)
 - B. 囊腫纖維化(cystic fibrosis)
 - C. 原發性肺纖維化(idiopathic pulmonary fibrosis)
 - D. 類肉瘤(sarcoidosis)
 - E. 原發性肺動脈高壓(idiopathic pulmonary hypertension)

(E) 15. 下列何者不是阻塞性呼吸睡眠中止症有關的誘發因子?

- A. 肥胖
- B. 男性
- C. 下巴較小
- D. 甲狀腺功能低下
- E. 鼻息肉

(C) 16. 下列有關原發自發性氣胸(primary spontaneous pneumothorax)的描述何者不正確?

- A. 病患無過去肺部疾病

- B. 常是肺尖的bleb破裂所致
- C. 初次發生後，約有10%的機會再復發
- D. 初次發生的一般治療原則是simple aspiration
- E. 病患常有吸菸史

(D) 17. 下列何者不是後縱隔腔腫瘤常見的原因？

- A. neurogenic tumor
- B. meningocele
- C. gastroenteric cyst
- D. bronchogenic cyst
- E. esophageal diverticulum

(D) 18. 下列關於原發性肺纖維化(idiopathic pulmonary fibrosis)的描述何者錯誤？

- A. 典型的病理變化是usual interstitial pneumonia
- B. 典型的高解析度電腦斷層變化是週邊下肺野的蜂窩狀線條影像
- C. 典型的肺功能變化是侷限型氣體交換障礙
- D. 吸入性類固醇是藥物治療的首選
- E. 是肺臟移植的適應症之一

(D) 19. 62歲男性，過去無吸菸史，此次因咳嗽三個月都沒改善，故至門診就醫，胸部X光檢查顯示右側有中量肋膜積液，以細針抽吸後檢驗發現肋膜積液的total protein為4.8 g/dL，LDH為298 U/L，同時病患血液中的total protein為5.8 g/dL(正常範圍為6.4 - 8.4 g/dL)，LDH為273 U/L(正常範圍為131 - 250 U/L)；肋膜積液中的白血球總數為2300 /cumm，嗜中性球為3%，淋巴球為97%，細胞學及抗酸性染色檢查皆為陰性。請問下列敘述何者最不適當？

- A. 根據Light's criteria，此肋膜積液應為exudate
- B. 若細胞學標本中的間皮細胞(mesothelial cell)比例不到3%，則結核性肋膜積液的機會很大
- C. 因為要在肋膜積液中直接找到結核菌的敏感性不到10%，所以抗酸性染色檢查為陰性，並不能排除結核性肋膜積液的診斷
- D. 因為要在肋膜積液細胞學檢查中發現惡性細胞的敏感性超過90%，所以細胞學檢查為陰性，應可排除惡性肋膜積液的診斷
- E. 可考慮做肋膜切片以幫助診斷

(D) 20. 下列何處有咳嗽接受體(cough receptor)？(1)上眼瞼，(2)鞏膜，(3)額頭，(4)口腔，(5)咽，(6)喉，(7)外耳道，(8)食道，(9)細支氣管

- A. (4)+(5)+(6)+(8)+(9)
- B. (2)+(5)+(6)+(8)+(9)
- C. (1)+(5)+(6)+(7)+(9)
- D. (5)+(6)+(7)+(8)+(9)
- E. (2)+(5)+(6)+(7)+(9)

- (B) 21. 請問下列哪些情況導致呼吸困難的機轉和呼吸功(work of breath)增加無關？(1)慢性阻塞性肺病，(2)氣喘，(3)肺動脈高壓，(4)貧血，(5)心因性肺水腫，(6)非心因性肺水腫，(7)間質性肺病，(8)去條件化(deconditioning)
- A. (4)+(6)+(8)
 - B. (3)+(4)+(8)
 - C. (2)+(5)+(7)
 - D. (3)+(4)+(5)
 - E. (1)+(2)+(7)
- (A) 22. 請問下列哪些原因造成的肋膜積液通常是transudate？(1)鬱血性心衰竭，(2)肝硬化，(3)肺栓塞，(4)藥物，(5)乳糜胸，(6)上腔靜脈阻塞，(7)Dressler's syndrome，(8)Meigs' syndrome
- A. (1)+(2)+(3)+(6)
 - B. (1)+(2)+(6)+(7)
 - C. (1)+(3)+(5)+(6)
 - D. (2)+(5)+(6)+(8)
 - E. (1)+(2)+(5)+(6)

< 一〇四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 消化科

- (D) 1. 患者主訴為吞嚥困難(dysphagia)，而且一開始發生即包括固體(solid)和流質(liquid)食物皆有問題，下列何者最不可能是此位患者吞嚥困難的原因？
- A. achalasia
 - B. scleroderma
 - C. gastroesophageal reflux disease with weak peristalsis
 - D. Schatzki ring
 - E. diffuse esophageal spasm
- (E) 2. 病患主訴腹瀉3個月，糞便檢查顯示無白血球、脂肪則為陽性。下列何者最有可能是造成此位患者腹瀉的病因？
- A. 大腸激燥症(irritable bowel syndrome)
 - B. 甲狀腺功能亢進(hyperthyroidism)
 - C. 大腸絨毛性腺瘤(villous adenoma)
 - D. 愛迪生氏病(Addison's disease)
 - E. 細菌過度增生(bacterial overgrowth)
- (B) 3. 患者在嘴唇有黑色的色素沈澱(如圖)，下列敘述何者錯誤？
- A. 腸胃道容易有息肉發生
 - B. 息肉的病理型態為腺瘤(adenoma)
 - C. 為自體顯性遺傳(autosomal dominant)
 - D. 發生卵巢腫瘤機會增加
 - E. 發生胰臟腫瘤機會增加
- (B) 4. 老年患者主訴為服用藥物後，有急性發作的胸痛合併吞嚥疼痛(odynophagia)，內視鏡檢查在食道發現如圖的變化(如圖)。下列敘述何者錯誤？
- A. 起因於不良的服藥習慣
 - B. 最容易發生於食道下端
 - C. 服用nonsteroidal anti-inflammatory drugs是可能的病因
 - D. 服用bisphosphonates也可以造成
 - E. 可以處方antisecretory medications
- (C) 5. 幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)是造成慢性胃炎，消化性潰瘍和胃癌的主要原因，下列何項藥物不適合用於除菌的合併治療？
- A. omeprazole
 - B. bismuth subsalicylate
 - C. erythromycin
 - D. metronidazole
 - E. amoxicillin

- (D) 6. 有關膽酸(bile acid)的敘述，何者正確？(1)飲食成分中不含膽酸(2)腸子合成的膽酸為初級膽酸(primary bile acid) (3)經由腸子吸收的膽酸會回到肝臟，此過程有問題會導致 steatorrhea (4)cholestyramine可用於bile acid diarrhea (5)deoxycholic acid和lithocholic acid為初級膽酸
- A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(3)+(4)
C. (3)+(4)+(5)
D. (1)+(3)+(4)
E. (2)+(4)+(5)
- (D) 7. 發炎性大腸疾病(inflammatory bowel disease)包括克隆氏症(Crohn's disease簡稱CD)和潰瘍性腸炎(ulcerative colitis簡稱UC)，容易有腸道以外的表現(extraintestinal manifestation)。下列何種腸道外表現較常見於CD？(1)pyoderma gangrenosum (2)ankylosing spondylitis (3)primary sclerosing cholangitis (4)episcleritis (5)peripheral arthritis
- A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(3)+(4)
C. (3)+(4)+(5)
D. (2)+(4)+(5)
E. (1)+(3)+(4)
- (D) 8. 急性胰臟炎的嚴重度判斷對患者處置和預後相當重要，過去的Ranson's sign(≥ 3)和APACHE II score (≥ 8)由於較繁瑣，目前有用bedside index severity取而代之的趨勢，下列何者不屬於bedside index severity of acute pancreatitis (BISAP)？
- A. age>60years
B. SIRS
C. pleural effusion
D. creatinine>2.0mg/dL
E. impaired mental status
- (C) 9. 藥物引起的肝臟傷害(drug-induced hepatic injury)，反應有direct及idiosyncratic兩種，下列藥物何者屬於idiosyncratic反應？(1)oral contraceptive agents (2)acetaminophen (3)halothane (4)isoniazid (5)chlorpromazine
- A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(3)+(4)
C. (3)+(4)+(5)
D. (1)+(3)+(4)
E. (2)+(4)+(5)
- (A) 10. 有關胃分泌(gastric secretion)的敘述，何者錯誤？
- A. 基礎胃酸分泌量在早上最高

- B. 除胃酸外，胃可分泌pepsinogen
 - C. 鐵質和B12的吸收與胃分泌有關
 - D. somatostatin可抑制胃酸分泌
 - E. parietal cell上有histamine, gastrin和acetylcholine受體
- (B) 11. 長期酗酒的患者因解黑便、吐血到急診處，內視鏡檢查結果(如圖)，下列何種處置不適合急性出血的控制？
- A. octreotide
 - B. propranolol
 - C. injection therapy(sclerotherapy)
 - D. transjugular intrahepatic portosystemic shunt
 - E. somatostatin
- (C) 12. 便秘 (constipation) 可能發生於下列情況，何者除外？
- A. Hypothyroidism
 - B. 服用Bismuth
 - C. Hypocalcemia
 - D. 服用calcium channel blockers
 - E. 服用opiates
- (B) 13. 大腸的diverticular diseases在中老年人相當常見，下列相關敘述，何者錯誤？
- A. Diverticulitis之典型症狀包括：左或右下腹痛、發燒及leukocytosis
 - B. 用來治療diverticulitis之抗生素應包括對抗aerobic gram-negative 及gram-positive細菌
 - C. Diverticulitis急性發作期不宜做內視鏡檢查
 - D. 若診斷不是很確定，abdominopelvic CT是首選檢查工具
 - E. Diverticula of colon 是血便的常見病因之一
- (E) 14. 一位72歲男性至急診就醫，主訴為過去二周有心窩痛，6小時前有吐出咖啡色物質。他過去曾接受手術換過mitral valve，也曾有過transient ischemic attack，現在一直服用warfarin。過去無肝病史。身體診察發現血壓為170/88 mmHg，無姿勢性低血壓，心跳為92/分，呼吸速率17/分，體溫正常，腹部檢查在心窩處有輕微壓痛。抽血檢查INR=2.3 (0.8-1.2), Hb : 13 g/dL (≥ 13.2), Albumin: 3.8 (≥ 3.7) g/dL, Bilirubin (total): 0.9 (≤ 1.0) mg/dL, AST: 31U/L (≤ 31), ALT: 25U/L (≤ 41)。下列何者為最迫切合宜之處置？
- A. 輸注Fresh frozen plasma
 - B. 輸注Vitamin K
 - C. 輸注Platelet
 - D. 給予預防性抗生素
 - E. 安排內視鏡檢查

- (A) 15. 一位60歲女性病人自述近2個月有逐漸加重的活動性氣促 (progressive exertional dyspnea)，她並無胸痛或心悸等現象，靜止或睡覺時亦無氣促情況。身體診察僅在胸前發現spider angiomas，其它無異常發現。抽血檢驗發現：PaO₂=62 mmHg，oxygen saturation 90%，AST=110 (≤ 31)，ALT=130 (≤ 41)，Alb=3.5 (≥ 3.7) g/dL，Bil(T)=0.9 (≤ 1) mg/dL，INR=0.95 (0.8-1.2)，WBC=4500 (≥ 3500)，Platelet=103K ($> 140K$)，HBsAg (-)，AntiHCV (+)。心電圖及胸部X光皆正常。下列何種診斷最可能？
- A. Hepatopulmonary syndrome
 - B. Portopulmonary hypertension
 - C. Ischemic heart disease
 - D. Decompensated liver cirrhosis
 - E. Idiopathic portal hypertension
- (D) 16. 一位肝硬化病人最近發生肝性腦病變 (hepatic encephalopathy)。住院後並未發現有腸胃道出血、感染及低血鉀等病情，他在家中每天於服用lactulose下解便約4次，生病前亦無進食過多蛋白質。增加下列何者給病人服用，有助於預防未來再發生肝性腦病變且不會有明顯可預期之副作用？
- A. Dulcolax
 - B. Neomycin
 - C. Metronidazole
 - D. Rifaximin
 - E. Anticholinergic drug
- (E) 17. 下列關於acute intestinal obstruction之敘述，何者錯誤？
- (1) 初期常有陣發性cramping mid-abdominal pain (2) Strangulation發生時，腹痛較會固定於某一部位，且變成持續性，也較不會cramping (3) Colon obstruction之腹痛較不嚴重 (4) 身體診察時，腹部脹氣越厲害，表示其阻塞部位較可能在近端小腸處 (5) 身體診察時，聽不到bowel sound，可排除acute intestinal obstruction之可能性 (6) 身體診察時，聽不到bowel sound，表示一定是發生adynamic (paralytic) ileus (7) Barium meal study是判斷阻塞部位之最好方式
- A. (1)+(2)+(3)+(4)
 - B. (2)+(3)+(4)+(5)
 - C. (2)+(3)+(6)+(7)
 - D. (3)+(4)+(5)+(6)
 - E. (4)+(5)+(6)+(7)
- (C) 18. 下列關於Acute Appendicitis之敘述，何者正確？ (1) 典型之腹痛是由periumbilical/epigastric region移行至right lower quadrant of abdomen (2) 常有bowel habit change (3) 常有anorexia (4) 身體診察時，在右下腹沒有發現tenderness，即可排除acute appendicitis之診斷 (5)

psoas/obturator sign對判斷acute appendicitis之有無極具價值 (6) 使用CT with contrast agent enhancement診斷acute appendicitis之準確率 (accuracy) 相當高，可達90%

- A. (1)+(2)+(3)
- B. (2)+(3)+(5)
- C. (1)+(3)+(6)
- D. (3)+(4)+(5)
- E. (4)+(5)+(6)

(E) 19. 下列關於肝臟局限性病灶 (focal lesion) 之敘述，何者正確？ (1) 大的cyst若有wall irregularity，應考慮切除之 (2) Focal Nodular Hyperplasia (FNH)有malignant potential，故應切除之 (3) 直徑5公分以上的adenoma可能會spontaneous rupture或演變成惡性腫瘤，故應切除之 (4) 接觸ameba至開始有liver abscess之臨床症狀，其潛伏期約2-4 weeks (5) 接受CT scan檢查，注射顯影劑後，在血管瘤會有所謂 "fill-in"現象，即是顯影劑會隨時間從血管瘤之周邊向其中中央滲入。

- A. (3)+(4)+(5)
- B. (2)+(3)+(4)
- C. (1)+(2)+(3)
- D. (2)+(3)+(5)
- E. (1)+(3)+(5)

(A) 20. 目前已有A型肝炎及B型肝炎疫苗，年輕一代之國人應接受之。下列相關敘述，何者錯誤？

- A. 若母親為HBeAg (-)之B型肝炎帶原者，其新生兒應於24小時內接受HBIG (hepatitis B immune globulin) 注射，並於一周內完成第一劑B型肝炎疫苗注射
- B. 目前之B型肝炎疫苗，應於六個月內完成三劑注射
- C. 目前之A型肝炎疫苗，應於六個月～一年內完成兩劑注射
- D. 完成三劑注射且產生anti-HBs後，60%以上可持續維持具保護性之濃度至少10年
- E. 完成二劑注射且產生anti-HAV後，應可持續維持具保護性之濃度至少20年

(B) 21. 在日常醫療之情況下，下列何種藥物最不會產生肝臟傷害？

- A. 降低血中尿酸濃度的allopurinol
- B. 退燒時使用acetaminophen (酒精成癮者除外)
- C. 治療結核病之isoniazid
- D. 治療足癬之ketoconazole類藥物
- E. 降低血中膽固醇之statin類藥物

(C) 22. 一位45歲男性病人因右上腹痛及皮膚癢而就醫，抽血檢驗結果如下：ALT=60U/L (≤ 41)，AST=70U/L (≤ 31)，

ALP=700 (≤ 104)，r-GT=450U/L (≤ 50)，
Bil(T)=1.2mg/dL，Bil(D)=0.8mg/dL。住院後接受磁共振造
影及膽胰管攝影（MRCP, magnetic resonance cholangio
pancreatography）發現肝內膽管有分布不一之狹窄及擴
大現象（segmental stricture with saccular dilatation）。
病人接受肝切片，其組織顯現portal tract expansion with
ductular proliferation and lymphocytic infiltration，此
病人之診斷因而已經確立。關於本病人之病情，下列各項
敘述，何者錯誤？

- A. 常合併有慢性發炎性腸道疾病（inflammatory bowel disease）
- B. 應隨時注意其是否併發cholangiocarcinoma
- C. 高劑量 (25 mg/Kg/d) UDCA (ursodeoxycholic acid) 能有效控制其病情
- D. 若病情惡化，可考慮肝臟移植
- E. MRCP用於診斷此等病人，其準確率可達90%

< 一〇四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 腎臟科

- (B) 1. 24歲女性病人因肌肉抽筋與全身乏力影響打電腦與走路而求診。理學檢查為：血壓 112/70 mmHg; HR 80/min, 呼吸 14/min, 全身肌力約4分。BUN 13.2 mg/dL, Cre 0.9 mg/dL, Uric acid 9.6 mg/dL, Na 136 mmol/L, K 2.6 mmol/L, Cl 85 mmol/L, Ca 2.38 mmol/L, Mg 0.9 mmol/L. Urine K 33.4 mmol/24/h, TTKG 11.74. Blood gas pH 7.53, PaCO₂ 49.3 mmHg, PaO₂ 98.0 mmHg, HCO₃⁻ 41.2 mEq/L, BE 15.8 mEq/L. Plasma renin activity 25.8 ng/ml/h (normal <5); Plasma aldosterone 64.4 ng/dL (normal <30)., 腎臟超音波(如圖)。請問何者為正確？ (1) Fanconi syndrome, (2) Bartter syndrome, (3) Gitelman syndrome, (4) 長期過度使用Thiazide, (5) 長期過度使用 Loop diuretics.
- A. (1)+(2)
B. (2)+(5)
C. (3)+(4)
D. (2)+(4)
E. (3)+(5)
- (D) 2. 73歲男性病人因最近五天眼眶周遭自然出現紫斑，自述之前無外傷或跌倒，過去無糖尿病或高血壓，也無服用止痛藥、阿斯匹林、抗凝劑等。理學檢查：全身他處皮膚無雷同症狀，下肢無水腫。但尿液檢查有尿蛋白3+, RBC 0-2/HPF, BUN 30 mg/dL, Cre 1.5 mg/dL, Albumin 3.3 gm/dL, 超音波顯示腎臟大小正常，皮質回音度稍增強，其他無異常。請問在建議做侵襲性檢查前，最好能選擇底下哪幾項檢查比較能(接近百分之百的靈敏度)來確定臆斷之正確否？ (1) Immunofixation of serum; (2) Immunofixation of urine, (3) Serum protein electrophoresis, (4) Urine Bence Jones Protein detection, (5) Serum immunoglobulin free light chain assay.
- A. (3)+(4)
B. (1)+(3)+(4)
C. (2)+(3)+(5)
D. (1)+(2)+(5)
E. (3)+(4)+(5)
- (C) 3. 請問底下所列降血壓之藥物，哪些可幫忙輸尿管結石之排出？ (1) Thiazide, (2) Loop diuretics, (3) Beta blockers, (4) alpha blockers (tamsulosin), (5) calcium blockers (nifedipine)
- A. (1)+(2)
B. (3)+(4)
C. (4)+(5)
D. (1)+(3)
E. (2)+(5)

- (A) 4. 58歲男性病人有糖尿病12年，高血壓與腳部水腫約半年。理學檢查 BMI 29，血壓 154/88 mmHg，脛骨前水腫+。尿蛋白 3+，URBC 0-2/HPF。Albumin 3.3 g/dL, BUN 33 mg/dL, Cre 1.8 mg/dL (eGFR 42 ml/min), Na 132 mmol/L, K 5.2 mmol/L, HbA1C 7.3. .請問下列處置何者是錯誤？(1) 因是慢性腎臟病第3b期，尚無須轉診至腎臟專科醫師。(2) 高血壓之出現代表腎功能將持續繼續惡化。(3) 若血糖能嚴格控制，亦難以降低心血管疾病之發生。(4) 若高血壓能嚴格控制(包括使用ACEI或ARB)可以減緩糖尿病腎病變與視網膜病變。(5) 病人血糖在高血壓與尿蛋白出現將更難控制。
- A. (1)+(3)
B. (2)+(5)
C. (2)+(3)
D. (4)+(5)
E. (3)+(5)
- (A) 5. 請問慢性腎臟病人中使用底下之藥物，何者或哪些不會加重血管鈣化？(1) Calcium containing phosphate binders; (2) non-ion based phosphate binders, (3) Vitamin D, (4) High calcium dialysate, (5) Warfarin。
- A. (2)
B. (2)+(3)
C. (2)+(5)
D. (2)+(3)+(4)
E. (2)+(3)+(5)
- (C) 6. 請問底下藥物何者是主要由腎臟排泄且腎功能欠佳時需調整劑量，但在藥物過量時卻無法以血液透析來排除？(1) Aspirin ; (2) Digoxin ; (3) Lithium (4) Tobramycin; (5) Vancomycin.
- A. (1)+(2)
B. (2)+(3)
C. (2)+(5)
D. (2)+(4)
E. (3)+(5)
- (A) 7. 45歲女性曾接受腎臟移植，正在服用 Tacrolimus及 Sirolimus，此外有服用避孕藥及因冠狀動脈阻塞曾放支架而服用 Clopidogrel，請問此病人容易罹患底下哪一種腎臟疾病？(1) Thrombotic thrombocytopenic purpura ; (2) Hemolytic uremic syndrome ; (3) Goodpasture syndrome ; (4) Henoch-Schonlein purpura ; (5) Microscopic polyangitis
- A. (1)+(2)
B. (3)+(4)
C. (3)+(5)

- D. (2)+(3)
- E. (2)+(5)

- (B) 8. 63歲女性病人有高血壓、退化性關節炎之過去史，因腎功能欠佳求診經檢查有尿蛋白++與尿紅血球5-10/HPF。血清肌酸酐 2.2 mg/dL，血紅素10 gm/dL。超音波顯示兩側腎臟均輕度萎縮各約9公分(如圖)，請問不可能之診斷為？ (1) Myeloma kidney; (2)nephropathy; (3)DM nephropathy; (4) Chinese herb nephropathy; (5)Lithium nephropathy
- A. (1)+(2)
 - B. (1)+(3)
 - C. (2)+(3)
 - D. (3)+(5)
 - E. (2)+(5)
- (B) 9. 依據目前之臨床證據，於第四期紅斑性狼瘡之誘發期，建議如何選擇免疫抑制劑而能有較佳療效且較少副作用？ (1) Monthly i.v. high dose cyclophosphamide; (2) Monthly i.v. high dose methylprednisolone, (3) Monthly i.v. Rituxumab, anti-CD20 monoclonal antibody. (4) Daily oral mycophenolate mofetil (5) Daily oral cyclosporine (6) Daily oral azathioprine
- A. (1)+(2)+(3)
 - B. (1)+(2)+(4)
 - C. (1)+(3)+(5)
 - D. (1)+(3)+(6)
 - E. (2)+(5)+(6)
- (A) 10. 病人因Transient Ischemia attack 正長期服用低劑量 Aspirin, 請問與下列哪些藥物會有交互作用？ (1) naproxen (2) Ibuprofen (3) COX-2 inhibitor (4) Acetaminophen (5) Diclofenac
- A. (1)+(2)
 - B. (1)+(2)+(4)
 - C. (2)+(3)+(4)
 - D. (2)+(4)+(5)
 - E. (2)+(3)+(4)+(5)
- (C) 11. 66歲婦人因憂鬱症吞服鈣離子阻斷劑與乙型交感神經阻斷劑(不知道幾粒)，經急診後篩檢發現血壓 70/50 mmHg, 心跳 45/min，心電圖有AV block 現象。請問底下哪些是不適當的特殊治療或處置？ (1) 給予大量生理鹽水; (2) Glucacon; (3) Vasopressors or inotropic agents; (4) Magnesium; (5) Electric pacing; (6) High dose insulin (with glucose and potassium); (7) 需要隨時檢測血糖及鉀離子
- A. (1)+(2)+(7)
 - B. (2)+(6)+(7)

- C. (1)+(4)
D. (6)+(7)
E. (1)+(2)+(6)
- (B) 12. 一位30歲女性，過去有IgA nephropathy與輕度蛋白尿，定期在門診就醫。最近懷孕並出現高血壓，以下高血壓相關藥物處置，何者最不適合？
A. 使用methyldopa
B. 使用ACEI 類降低蛋白尿，預防發生pre-eclampsia
C. 使用 labetalol
D. 使用Long-acting nifedipine
E. 使用hydralazine
- (B) 13. 一位52歲男性，有三年的nephrotic syndrome病史，定期在門診就醫。最近一個月出現雙下肢水腫，體重增加了4公斤，尿蛋白從2.8 g/day增加到10.6 g/day。醫師懷疑有venous thromboembolism合併症。以下敘述，何者不正確？
A. 可能是發生deep vein thrombosis或renal vein thrombosis
B. 原因通常是platelet 數目增加或antithrombin III activity增加所致
C. 可能原因是protein C或protein S減少所致
D. 通常先以超音波做篩檢(screening test)，必要時再安排CT 或MRI檢查
E. 使用 heparin 或warfarin治療
- (C) 14. 一位24歲外表健康女性，健康檢查發現: urine protein (2+)，urine occult blood test (2+)，Hb 9.4 g/dL，WBC 7,650/mm³，serum creatinine 1.8 mg/dL，補體C3與C4較正常值偏低。病人最可能是以下何種腎絲球腎炎(glomerulonephritis)?
A. IgA nephropathy
B. Henoch-Schonlein purpura
C. Acute poststreptococcal nephritis
D. Mesangial proliferative glomerulonephritis
E. Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS)
- (A) 15. 一位多囊腎(polycystic kidney disease)的病人，因發燒、腰痛住院，診斷為cystic infection。考量抗生素對個別腎臟囊泡(cyst)的穿透性，以下何種抗生素較不適用？
A. Aminoglycoside
B. Clindamycin
C. Ampicillin或Erythromycin
D. Fluoroquinolone
E. Metronidazole

- (A) 16. 一位住院病人，抽血發現[Na] 120 mmol/L，針對低血鈉症(hyponatremia)，進一步檢查尿液滲透壓(urine osmolality) 大於 280 mOsm/L，尿液的鈉離子濃度32 mmol/L。病人的低血鈉症最可能是以下何種病因？
- A. SIADH (Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)
 - B. Primary polydipsia
 - C. Liver cirrhosis
 - D. Heart failure
 - E. Nephrotic syndrome
- (D) 17. 一位54歲病人，一年前因為蛋白尿，接受腎臟切片(renal biopsy)病理檢查，診斷是Membranous nephropathy (MN)，之後持續於門診追蹤。最近實驗室檢查結果(和一年前類似)，為: [Albumin] 3.8 g/dL，[creatinine] 1.2 mg/dL，蛋白尿1.6 g/day。病人有輕度高血壓，但是沒有水腫。現階段針對此病人的處置，何者較合適？
- A. 使用低劑量prednisolone，約2.5 mg/kg/day，預防疾病惡化
 - B. 應該使用Cyclosporine 或 tacrolimus，可以促進緩解(remission)
 - C. 單獨使用Mycophenolate mofetil (MMF)，可以更降低蛋白尿，保護腎臟
 - D. 尚無需使用prednisolone或其他免疫抑制劑，可以使用ACEI類藥物控制血壓
 - E. 應該再安排一次腎臟切片(renal biopsy)，追蹤病理變化
- (C) 18. 一位48歲慢性腎臟病人(CKD stage IV, eGFR 18)，因為有疑似腹部腫瘤，接受核磁共振(MRI, with Gadolinium-contrast)，兩日後出現寡尿(oliguria)，全身肌肉與皮膚疼痛。此病人最可能是發生哪種病狀？
- A. Acute tubular necrosis
 - B. Rhabdomyolysis
 - C. Nephrogenic systemic fibrosis
 - D. Obstructive acute kidney injury
 - E. Dehydration-induced acute kidney injury
- (B) 19. 有關chronic tubulointerstitial nephritis病人的尿液檢驗，以下敘述組合何者最正確？(1) 用Hansel stain可以見到eosinophiluria (2) 沒見到WBC cast (3) 見到granular cast (4) 蛋白尿(proteinuria) > 1-2 g/day (5) 有潛血反應[occult blood test (+)], 及WBC 40-50/HPF，但是病人並無泌尿道不適症狀
- A. (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
 - B. (1)+(3)+(5)
 - C. (2)+(3)+(4)
 - D. (3)+(4)+(5)

E. (1)+(3)+(4)

- (C) 20. 一位52歲女性，主訴發燒、噁心嘔吐、胃口變差和腹痛持續了一個星期。病人因紅斑性狼瘡腎炎及尿毒症，接受腹膜透析約15年。透析液外觀清澈，腹水化驗白血球小於100 cells/uL。臨床上出現腸阻塞之症狀，腹部電腦斷層(CT)可看到有腸道擴張及腸壁鈣化，且被鈣化的臟層腹膜包覆起來。以下敘述，何者正確? (1) 可能是腹膜透析發生細菌性腹膜炎(bacterial peritonitis), 或黴菌性腹膜炎(fungal peritonitis) (2) 可能是發生包囊性腹膜硬化症(encapsulating peritoneal sclerosis) (3) 可以用tamoxifen，或免疫抑制劑(如類固醇，corticosteroid)治療 (4) 可以用乙型阻斷劑(beta-blocker)治療 (5) 使用高糖濃度透析液，增加灌洗次數，可預防腹腔內沾黏，並補充營養
- A. (1)+(2)+(5)
B. (1)+(3)+(5)
C. (2)+(3)
D. (2)+(3)+(4)
E. (2)+(3)+(5)

- (A) 21. 一位51歲男性，身材微胖，兩個月前例行性健檢發現有高血壓(152/94 mm Hg)。病人至你的門診就醫，測得血壓值148/90 mm Hg，依照2015年出版的台灣高血壓指引，除了檢查serum creatinine，urinalysis等，及lipid parameters之外，建議安排以下實驗室例行檢查，何者除外?
- A. Renal ultrasonography
B. Hemoglobin or hematocrit
C. Serum uric acid level
D. Fasting glucose level
E. Electrocardiogram (ECG) or chest X-ray

- (B) 22. 低血鉀的原因可以大致歸類為Thyrotoxic periodic paralysis (TPP)與hypokalemic non-periodic paralysis (HNPP)兩類。這些病人在補充鉀的輸液治療中，血清鉀濃度有時反而更低，這稱之為"Paradoxical hypokalemia"。以下有關Paradoxical hypokalemia的敘述，何者正確?
- A. 一般而言，當要矯正低血鉀，TPP比HNPP的病人需要補充更多的鉀
B. 一般而言，當矯正低血鉀時，TPP比HNPP的病人更常發生rebound hyperkalemia.
C. 一般而言，當矯正低血鉀時，TPP比HNPP的病人更常發生Paradoxical hypokalemia
D. TPP的病人發生Paradoxical hypokalemia的原因，通常與體液容積不足(hypovolemia)或renin-aldosterone活性過高有關
E. HNPP的病人發生Paradoxical hypokalemia的原因，通常與血壓高有關，所以可以使用beta-blocker來預防

< 一〇四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 考古題

- (E) 1. 具有高度猝死危險性的肥厚心肌病包括有：(1)心尖巨大T波心肌肥厚 (2)家族有猝死病人 (3)左心室出口高壓閾差 (pressure gradient) > 50 mmHg (4)成年人肥厚心肌病 (5)心肌肥厚 > 20 mm
- A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(3)+(4)
C. (3)+(4)+(5)
D. (1)+(3)+(5)
E. (2)+(3)+(5)
- (B) 2. 十八歲女性，突然發燒、頭痛及嘔吐，8小時後住院，身體檢查發現病人嗜睡、體溫40°C，在下肢可見紫斑性皮疹以及頸項僵直、末梢血白血球 $23 \times 1000/\mu\text{L}$ 分類明顯左移，CSF檢查發現白血球 $10 \times 1000/\mu\text{L}$ ，多形核佔95%，葡萄糖10 mg/dL，蛋白質90 mg/dL，CSF沈渣抹片染色鏡檢發現革蘭陰性雙球菌。最可能的診斷是：
- A. 淋菌性腦膜炎
B. 腦膜炎球菌性腦膜炎
C. 嗜血流行感冒桿菌性腦膜炎
D. 結核性腦膜炎
E. 肺炎球菌性腦膜炎
- (E) 3. 72歲男性糖尿病20年，最近尿素氮 (BUN) 32 mg/dl、肌酸酐 (creatinine) 1.8 mg/dl，其腎素 (renin) 及皮質醛酮 (aldosterone) 皆偏低，您預測此人酸鹼平衡如何？
- A. 完全正常
B. 鉀低，代謝性酸中毒 (Hypokalemia, metabolic acidosis)
C. 鉀低，代謝性鹼中毒 (Hypokalemia, metabolic alkalosis)
D. 鉀高，代謝性鹼中毒 (Hyperkalemia, metabolic alkalosis)
E. 鉀高，代謝性酸中毒 (Hyperkalemia, metabolic acidosis)
- (A) 4. 下列有關暴食症 (bulimia) 的敘述，何者有誤？
- A. 患者在暴食後會感到舒暢
B. 暴食的內容主要是碳水化合物類食物
C. 常會併發低血鉀症
D. 暴食症藥物治療之主線藥為抗鬱劑
E. 暴食症患者之體重多在正常範圍
- (E) 5. 下列因素均可能引起老年人的譫妄 (delirium)，何者除外？
- A. 尿道炎
B. 代謝障礙

- C. 肺炎
- D. 藥物
- E. 心理壓力

(A) 6. 下列有關肺炎之敘述，何者正確？

- A. *Legionella pneumophila* 引起者，尿液抗原檢查可早期診斷
- B. *Pneumocystis carinii* 引起者，痰培養是最佳確認方法
- C. *Mycoplasma pneumoniae* 引起者，痰抹片即可確定診斷
- D. SARS冠狀病毒引起者，起始都呈現大葉性肺炎
- E. *Aspergillus fumigatus* 只會發生在本來有空洞的肺病灶

(A) 7. 有關胃腸道出血，下列敘述何者錯誤？

- A. 急性出血時，出血量多少之判斷，主要依靠血中的hemoglobin數值
- B. 鼻胃管抽取液不含血液（non-bloody）時，表示上消化道出血之機率不大
- C. 急性出血時，應注意病人有無姿勢性（postural）低血壓或心跳變快
- D. 慢性出血患者，可能血紅素數值已明顯降低，但病人的血壓與心跳仍維持正常
- E. 解血便時，大多來自下消化道出血

(D) 8. 在加護病房中使用人工呼吸器並發生譫妄(delirium)的個案，與沒有發生譫妄的個案相較，前者比較容易發生下列何種現象？(1) 住院日數增加。(2) 六個月內死亡率上升。(3) 出院時認知功能缺損較嚴重。(4) 使用較少的鎮靜藥(sedatives)。(5) 住院期間使用呼吸器日數較短。

- A. (2)+(3)+(4)
- B. (2)+(3)+(5)
- C. (1)+(3)+(5)
- D. (1)+(2)+(3)
- E. (2)+(4)+(5)

(C) 9. 下列有關骨代謝的敘述，何者為非？

- A. BMPs (bone morphogenic proteins) 為成骨細胞(osteoblast) 之分化所需
- B. M-CSF (macrophage colony-stimulating factor) 是破骨細胞(osteoclast) 分化所需
- C. RANK (receptor activator of nuclear Factor κ B) ligand是破骨細胞分泌
- D. Osteocalcin, Osteopontin, Alkaline Phosphatase是成骨細胞分泌
- E. Cross-linked N-telopeptide血濃度可代表骨吸收之強度

- (D) 10. 有一21歲女性因體重於一個月內下降5公斤，心悸、手抖來就診，體檢發現手抖、多汗、Gr I 甲狀腺腫、free T4 3.8ng/ml、hsTSH<0.1μU/ml、AMA1:56000x(+)，口服 propylthiouracil 300 mg per day、inderal 30mg per day 後一星期，病人因皮膚癢再來求診，以下敘述何者恰當？
(1)皮膚癢是抗甲狀腺藥物最常見之副作用 (2)將 propylthiouracil改成 methimazole即可 (3)減少 propylthiouracil劑量即可 (4)只要加上抗組織胺即可。
- A. (1)+(2)
B. (2)+(6)
C. (3)+(4)
D. (4)+(1)
E. (1)+(3)
- (E) 11. 有那些病原菌的感染，在帶有HLA-B27或其他特殊遺傳背景的人有可能引起reactive arthritis? (1) TB bacilli (2) Yersinia (3) Salmonella (4) Shigella (5) E. coli
- A. (1)+(2)+(4)
B. (1)+(2)+(3)
C. (2)+(3)+(5)
D. (2)+(4)+(5)
E. (2)+(3)+(4)
- (A) 12. 一位70歲的婦人，主訴右側膝關節腫痛已3天，X光檢查看到osteophytes及關節腔有線狀鈣化點。關節液檢查，初步結果是白血球26000 cells/mm³，其中PMN佔80%，Gram's stain為陰性。請問最不可能的診斷為何？
- A. Avascular necrosis
B. Gouty arthritis
C. Calcium pyrophosphate dihydrate deposition arthritis
D. Bacterial septic arthritis
E. Reactive arthritis

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 感染科

- (C) 1. 台灣地區夏天登革熱疫情增溫，病例數快速上昇，下列關於登革熱的描述，何者最不適當？
- A. 登革病毒為黃病毒科(Flaviviridae)，為RNA病毒，盛行於鄰近赤道區域，包括中南美洲、東南亞及非洲
 - B. 在台灣，登革熱主要的傳染病媒為白線斑蚊及埃及斑蚊。埃及斑蚊多分佈在南部，喜歡棲息在室內；白線斑蚊全島分佈，喜歡棲息在室外。
 - C. 登革休克症候群原因為病人出現血漿滲漏導致血壓下降，即使早期給予病患適當的靜脈輸液及支持性治療，登革休克症候群之死亡率仍有40%~50%。
 - D. 檢驗登革熱可測病人血清登革病毒特異性IgM陽性或IgG抗體陽轉或有4倍上升確診。
 - E. 登革熱病毒分為4種血清型，感染血清型第一型後再感染第二型病症最為嚴重。
- (B) 2. 梅毒為由梅毒螺旋體所引致之一種性傳染病，以下敘述，何者最不適當？
- A. 治療首選為Penicillin，若病患為Penicillin過敏時，可改用Doxycycline治療
 - B. 胎兒先天性梅毒大多源自梅毒螺旋體在胎兒出生通過產道時傳染
 - C. 葡萄膜炎(Uveitis)為梅毒在眼睛感染可見的表現
 - D. 隱性(latent)梅毒是指梅毒進入完全無臨床症狀的時期。早期隱性梅毒為感染後未超過1年之無症狀期，病患仍具較高傳染性；晚期隱性梅毒則指感染超過1年之無症狀期，傳染力較弱
 - E. 早期先天性梅毒臨床症狀似後天性二期梅毒，而晚期先天性梅毒典型症狀為梅毒腫、間質性角膜炎、耳聾、Hutchinson氏齒等
- (C) 3. 一位32歲男性於10天前至陽明山遊玩，2天前開始出現發燒、頭痛、鼠蹊部淋巴腺腫，皮膚出疹，並於腹股溝下緣發現有一焦痂病灶(如圖)，此時下列何種診斷及治療是最錯誤的？
- A. 此為Scrub typhus，病原體為Orientia tsutsugamushi。
 - B. 此病原是由恙蟲(chigger)叮咬所引起；秋天最常見，診斷可利用血清免疫反應(IFA)或PCR診斷。
 - C. 潛伏期為6至21天，超過90%患者臨床症狀會出現此焦痂病灶及皮疹。
 - D. 治療可用doxycycline 100mg Bid治療7-15天。
 - E. 若病患對doxycycline過敏，可以使用azithromycin 500mg QD三天治療。
- (D) 4. 下列何者抗菌藥物屬於懷孕分類Category B可以適合孕婦使用？

- A. Aminoglycoside
- B. Fluoroquinolone
- C. Clarithromycin
- D. Erythromycin estolate
- E. Sulfonamide

(E) 5. 下列抗菌藥物之副作用配對，何者為非？

- A. Aminoglycosides - 8th Cranial nerve toxicity
- B. Clindamycin - Clostridium difficile colitis
- C. Levofloxacin - 心電圖 QTc prolongation
- D. Metronidazole - 與Alcohol併用引起Disulfiram reaction
- E. Macrolides - Renal toxicity

(E) 6. 下列有關Listeria monocytogenes之敘述，何者錯誤？

- A. 兼性厭氧，習慣於較冷環境存活的格蘭氏陽性桿菌。
- B. 懷孕婦女、器官移植病患和人類免疫不全病毒感染患者是感染高危險群。
- C. 接觸及食用汙染的食物是主要感染途徑。
- D. 首選治療藥物是ampicillin，對於ampicillin過敏者可優先選擇trimethoprim-sulfomethoxazole(TMP-SMX)治療。
- E. 若為腦膜炎個案可使用IV Ceftriaxone 2g Q12H治療。

(D) 7. 下列抗菌藥物何者非主要經由腎臟代謝，故不需依腎功能調整劑量？

- A. Cefazolin
- B. Levofloxacin
- C. Penicillin
- D. Metronidazole
- E. Vancomycin

(D) 8. 有關肺結核(Tuberculosis)之敘述，下列何者為正確？(1). 初感染之後，一般人終其一生體內結核菌再度活化而發病的機率約為5~10%，其中約有一半是在感染後的前五年發病，而以第一年的危險性最大。(2). 經由驗痰發現結核菌，是肺結核最為重要的診斷依據。(3). 再活化肺部感染疾病(reactivation)好發於肺尖(apical)及肺上葉(upper lobes)之前節(anterior segments)。(4). 當痰液中找不到結核菌時，亦可由胸部X光檢查結果加上病人的臨床症狀，做為肺結核的臨床診斷依據。(5). 發燒、夜間盜汗及體重減輕是肺結核常見的症狀，約有50%~60%的肺結核個案會出現咳血。

- A. (2)+(3)+(4)。
- B. (1)+(3)+(5)。
- C. (3)+(4)+(5)。
- D. (1)+(2)+(4)。
- E. (1)+(2)+(3)+(4)+(5)。

- (D) 9. 一位40歲女性，颱風過後於家中清理淤水，一週後出現發燒，頭痛，全身痠痛，食慾不振，送醫院後，發現眼結膜充血，且有黃疸和急性腎衰竭，下列診斷及處置，何者正確？(1) 優先考慮鉤端螺旋體病(Leptospirosis)。(2) 診斷主要依據細菌培養及PCR。(3) 首選治療藥物可使用Penicillin。(4) 重症者可使用Ceftriaxone治療。
- A. (2)+(3)+(4)。
B. (1)+(2)+(4)。
C. (1)+(2)+(3)。
D. (1)+(3)+(4)。
E. (1)+(2)+(3)+(4)。
- (B) 10. 以下關於狂犬病的相關描述何者為正確：(1) 致病原Rabies virus是一種RNA病毒，為Lyssavirus屬。(2) 狂犬病為第一類法定傳染病，應於24小時內通報。(3) 人類感染之潛伏期約為3週至3個月，發病時會有焦慮、頭痛、發燒、咬傷部位異樣感、恐水、肌肉麻痺、抽搐等腦炎症狀，最後因心肺或多重器官衰竭而導致死亡。(4) 當疾病的症狀一旦發展出來時，疫苗和狂犬病免疫球蛋白可將致死率降至60%。(5) 旅遊到菲律賓、越南、印度、泰國等國家，建議接受暴露前預防三劑狂犬病疫苗。
- A. (1)+(2)+(4)
B. (1)+(2)+(3)+(5)
C. (2)+(3)+(4)
D. (3)+(4)+(5)
E. (1)+(2)+(4)+(5)
- (D) 11. 在下列關於肉毒桿菌的敘述何者錯誤？
- A. 革蘭氏陽性，極厭氧之產孢桿菌，毒素是其致病因子。
B. 以食因型肉毒桿菌中毒最為常見。通常在食入受毒素污染的食物後，約12至36小時後發病。
C. 頭頸部的神經症如視力模糊或複視、眼瞼下垂、顏面神經麻痺、吞嚥困難及講話困難等。
D. 嚴重病人送到急診主要呈現代謝性酸血症，治療以intensive care和抗毒素為主軸。
E. 第四類法定傳染病，發現個案於24小時內通報疾管署。
- (A) 12. 有一位45歲男性病人，因發燒及下肢軟組織感染而至急診處就診接受傷口清創，感染病灶之膿液培養長出社區型methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)，下列何種口服藥物最不適合用於治療此病人？
- A. Ciprofloxacin
B. Fusidic acid
C. Linezolid
D. Sulfamethoxazole/ trimethoprim
E. Doxycycline

- (E) 13. 有關新型流感H5N1及H7N9 流感病毒感染之敘述，下列何者為非？(1) H5N1具有對人類下呼吸道細胞 α 2,3-linked sialic acid接受器結合之能力，易造成急性肺損傷；(2) H7N9具有對人類呼吸道上皮細胞 α 2,6-linked sialic acid接受器結合之能力；(3) H5N1與H7N9流感病毒皆曾在中國大陸發生人傳人群突發流行；(4) H5N1與H7N9流感病毒皆對於鳥禽類為高致病性及高致死率感染；(5) H7N9與H5N1大部份病毒株對現行藥物neuraminidase inhibitor（如oseltamivir）具有感受性，而對amantadine則具有抗藥性。
- A. (2)+(4)+(5)
B. (3)+(4)+(5)
C. (1)+(2)+(3)
D. (1)+(3)+(5)
E. (2)+(3)+(4)
- (C) 14. 在台灣，下列疾病與抗生素治療選擇之組合中，何者是恰當之治療選擇？(1) Actinomycosis - Cephalexin；(2) Nocardiosis - Trimethoprim／sulfamethoxazole；(3) Listeria monocytogenes infection - ceftriaxone；(4) Cat-scratch disease - azithromycin；(5) Legionellosis - Azithromycin
- A. (1)+(2)+(3)
B. (1)+(3)+(4)
C. (2)+(4)+(5)
D. (3)+(4)+(5)
E. (1)+(4)+(5)
- (E) 15. 下列有關Varicella-zoster virus (VZV)病毒感染或預防的敘述，何者正確？(1) 此病毒為雙股DNA病毒，初次感染途徑主要為呼吸道傳播；(2) 初次感染後潛伏在脊髓背根神經(dorsal root ganglia)，易復發於胸椎至腰椎皮節；(3) 大於60歲者，若接受VZV疫苗，可減少帶狀皰疹的發生及減輕皰疹後的神經疼痛(post-herpetic neuralgia)；(4) 對於嚴重免疫不全患者（如器官移植患者），發生水痘或帶狀皰疹皆應治療，靜注Acyclovir可降低內臟侵犯之合併症；(5) 帶狀皰疹神經痛很難治療，若要使用類固醇，則應同時用抗病毒藥。
- A. (1)+(2)+(3)
B. (1)+(2)+(4)
C. (1)+(2)+(5)
D. (1)+(2)+(3)+(4)
E. (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
- (D) 16. 一位38歲台商自大陸返台後，發現HIV感染及肺部感染M. tuberculosis，CD4檢查為100 cell/mm³，下列敘述何者正確？(1) 除立即投與抗結核藥物外，亦應同時開始highly active anti-retroviral therapy (HAART)；(2) 患者此時已是AIDS；(3) 立即投與抗結核藥物，並將患者轉至負壓隔離病

房; (4) 患者需儘快接受抗病毒藥物治療，改善免疫系統; (5) 患者先接受至少6個月抗結核藥物治療後，才能開始接受抗病毒藥物治療。

- A. (1)+(2)+(3)+(4)
- B. (1)+(3)+(4)
- C. (2)+(3)+(4)
- D. (2)+(3)
- E. (2)+(3)+(5)

(C) 17. 有關伊波拉病毒感染何者錯誤？

- A. 初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛與咽喉痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。
- B. 傳染源主要為果蝠
- C. 主要透過接觸傳染，人與人之傳染是因直接接觸到被感染者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液；或是間接接觸被感染者體液污染的環境而感染，且常見有空氣微粒(aerosols)傳播案例。
- D. 醫護人員被感染之情況在非洲頗為常見，主要是因為醫護人員照顧病患時未遵守適當的防護措施（如洗手、配戴標準防護裝備等）。
- E. 伊波拉病毒目前 (up to March 2015) 尚無確定有效人用疫苗可供預防接種。

(B) 18. 有關流感重症好發對象和社區感染肺炎之敘述，下列何者正確？(1) 流感重症好發於出生到4歲的兒童; (2) 流感重症好發於孕婦; (3) 流感重症好發於65歲以上有慢性心肺疾病者; (4) 社區感染肺炎由肺炎鏈球菌造成者年齡愈大發生率愈高，而非典型肺炎（黴漿菌、披衣菌和退伍軍人菌）則好發於小孩; (5) 造成嚴重社區感染肺炎主要致病原是肺炎鏈球菌和退伍軍人菌。

- A. (1)+(3)+(4)+(5)
- B. (1)+(2)+(3)+(5)
- C. (1)+(2)+(3)+(4)
- D. (2)+(3)+(4)+(5)
- E. (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(C) 19. 以下有關抗微生物製劑之副作用，何者錯誤？

- A. Vancomycin靜脈注射若太快可能導致Red man syndrome
- B. Fluoroquinolones若用於使用抗心律不整藥物的患者或電解質不平衡者，應留意QTc延長之不良反應。
- C. 降低aminoglycoside腎毒性的方式是採一日多次劑量給予。
- D. Amphotericin B最主要的副作用是腎毒性，每次輸注前各給予500ml生理食鹽水及減緩輸注速度可降低副作用。

- E. Terbinafine用於治療甲癬，有時造成嚴重藥物性肝炎，對於肝腎疾病患者應避免使用。

< 一〇四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 內分泌科

- (E) 1. 69歲男性有chronic stable angina pectoris，半年前心導管檢查發現單一血管冠心病（左前下支），病人目前使用Atenolol 100 mg qd 及Aspirin 80 mg qd，身體檢查發現皮膚乾燥有些浮腫，抽血發現膽固醇320 mg/dl，LDL 166 mg/dl，HDL 34 mg/dl，hsTSH 62 uU/ml，free T4 0.4ng/dl，下列治療方式那一種最好？
- A. 給予預防性anticoagulant治療及甲狀腺素100 ug qd
 - B. 給予甲狀腺素75 ug qd及三碘甲素25 ug qd
 - C. 給予甲狀腺素100 ug qd及 Cortisone Acetate 25 mg qd
 - D. 給予甲狀腺素100 ug qd及statin
 - E. 給予甲狀腺素25ug qd
- (E) 2. 69歲女性第二型糖尿病20年，BMI 41.7 kg/M2，用Glimepiride 2 mg qd 控制，但6個月內發生3次低血糖，須住院治療，因此停用Glimepiride，身體檢查發現有神經病變及Romberg's sign(+)，血壓175/70 mmHg，甲狀腺有GrI腫大，抽血檢查AC 134 mg/dl，Cr 1.9mg/dl，HbA1c 6.8%，microalb/Cr=3130 mg/g，K 4.4 mEq/L，TSH 24.0 uU/ml。下列治療中，您會建議哪一項？
- A. 改為NPH insulin hs
 - B. 恢復Glimepiride
 - C. 改用Pioglitazone
 - D. 改用Repaglinide
 - E. 開始甲狀腺素治療
- (D) 3. 25歲男性因體檢發現高血鈣來診，病人主訴健康狀況良好，未曾有尿路結石病史，他也未服用維他命D及鈣片，體檢BMI 27.5 kg/M2，血壓122/84 mmHg，抽血檢查 Alb 4.0 gm/dl，Cr 0.9 mg/dl，ALK phosphatase 120 U/L，Ca 11.1 mg/dl，P 3.0 mg/dl，iPTH 49 pg/ml，Urine Ca 70 mg/day，最可能診斷是？
- A. Sarcoidosis
 - B. VitD intoxication
 - C. Primary hyperparathyroidism
 - D. Familial hypocalciuric hypercalcemia
 - E. Hypercalcemia of malignancy
- (A) 4. 56歲女性因偶然發現右頸有腫塊，體檢發現是右側甲狀腺結節，超音波發現為2X2公分周邊平滑，細針穿刺是follicular neoplasm，抽血檢查free T4 1.71 ng/dl，hsTSH 0.1 uU/ml，下列處置何者為最適當？
- A. I-131 uptake & scan
 - B. 甲狀腺素抑制治療
 - C. 觀察追蹤
 - D. 開刀切除

E. 頸部電腦斷層檢查

- (A) 5. 36歲男性因下肢無力來急診，他最近被發現有高血壓，以利尿劑控制，此外無特別病史。體檢發現血壓150/90 mmHg，抽血檢查 Na 143 mEq/L，K 2.6 mEq/L，CL 100 mEq/L，plasma Aldosterone (PA) 29 ng/dl，plasma renin activity (PRA) <0.6 ng/ml/h，下列那一檢查最恰當？
- A. saline suppression test 測PA
 - B. 測血中18-hydroxycorticosterone
 - C. postural stimulation test測PA, cortisol, PRA, K
 - D. adrenal venous sampling 測PA及 cortisol
 - E. CT of adrenal gland
- (C) 6. 60歲男性因耳鳴做了頭部核磁共振，發現腦下垂體有一5mm腺瘤而來診，除了耳鳴外病人並無其他不適，外觀亦無內分泌疾病外觀。抽血檢查 Cortisol 8 AM 15ug/dl，plasma ACTH 20 pg/ml，FSH 4 IU/L，LH 5 IU/L，free T4 1.1 ng/dl，Testosterone 427 ng/dl，IGF-1 165 ng/ml，TSH 1.0 uU/ml。下列處置何者最恰當？
- A. Transsphenoidal surgery
 - B. gamma-knife radiotherapy
 - C. No treatment
 - D. Octreotide therapy
 - E. Dostinex therapy
- (E) 7. 55歲女性一年前開始因腰酸背痛接受不明藥物治療，每次服用後酸痛消失，不用幾天後酸痛又來，一年來體重增加20公斤，圓臉，皮膚變薄，時感倦怠，抽血檢查ACTH 8AM <10 pg/ml，Cortisol 3.0 ug/dl，目前使用藥物為 dexamethasone 0.5mg qd，Celebrex 200 mg b.i.d.，Nexium 20 mg qd，gabapentin 600mg q.i.d.。下列措施那一項最恰當？
- A. 做腦垂體核磁共振
 - B. 做ACTH stimulation test
 - C. 增加Dexamethasone 為1 mg b.i.d.
 - D. 停止使用gabapentin
 - E. 慢慢taper 糖皮素並做復健
- (D) 8. 60歲男性有高血壓病史20年，最近2年血壓難以控制，目前降血壓藥為amlodipine 10mg，Betacloc 100 mg qd，Losartan 100 mg qd，Clonidine 0.1 mg qd，hydrochlorothiazide 25 mg qd，腹部電腦斷層發現右側腎上腺3公分腫瘤。請問在評估此腫瘤須做那一些檢查對診斷最有幫助？(1) BUN、Cr (2) Na、K、CL (3) plasma aldosterone，plasma renin activity (4) 腎上腺腫瘤細針穿刺 (5) Overnight 1 mg dexamethasone suppression test (6) MIBG Scan (7) Plasma metanephrine
- A. (1)+(2)+(3)+(4)

- B. (2)+(3)+(4)+(5)
C. (3)+(4)+(5)+(6)
D. (3)+(5)+(7)
E. (2)+(4)+(6)
- (A) 9. 58歲女性最近心悸、體重減輕5 Kg/3月，怕熱，抽血檢查 Free T4 2.3ng/dl hsTSH<0.01 uU/ml，因背痛做BMD（腰椎）T score -2.7，此病人之骨鬆症，下列血液檢查何者正確？
- A. Ionized Ca ↑ PTH ↓ Osteocalcin ↑ N-Telopeptide ↑
B. Ionized Ca ↓ PTH ↑ Osteocalcin ↑ N-Telopeptide ↑
C. Ionized Ca ↑ PTH ↑ Osteocalcin ↑ N-Telopeptide ↑
D. Ionized Ca ↑ PTH ↓ Osteocalcin ↓ N-Telopeptide ↓
E. Ionized Ca ↓ PTH ↓ Osteocalcin ↓ N-Telopeptide ↓
- (B) 10. 29歲女性因體重在2年內增加30kg來診，身體檢查發現有中央性肥胖，圓臉及下腹紫色條紋，血壓150/100 mmHg，下列哪些檢查為必要 (1) serum ACTH (2) Urine free cortisol (3) Plasma metanephrine (4) overnight dexamethasone suppression test (5) low dose dexamethasone suppression test (6) high dose dexamethasone suppression test
- A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(5)+(6)
C. (1)+(5)+(6)
D. (3)+(4)+(5)
E. (2)+(4)+(6)

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 新陳代謝科

- (A) 1. 63歲男性第2型糖尿病14年，以口服降血糖藥物控制，最近半年來飯前血糖150-160 mg/dl，飯後血糖200 mg/dl，HbA1c 8.5%，主治醫師使用Lantus 10 u hs來改善血糖，請問血糖追蹤來調整以何者為準？
- A. 早飯前血糖
 - B. 早飯後血糖
 - C. 睡前血糖
 - D. 晚飯前血糖
 - E. 打針後2小時
- (B) 2. 64歲男性第2型糖尿病18年，有視網膜病變、神經病變、周邊血管病變，2天前因大腳趾（右）受傷，現腳掌及踝部紅腫疼痛，下一步處置何者最佳？
- A. 踝部固定7天，之後輕度重力承擔
 - B. 做腳踝核磁共振
 - C. 做脊椎、下肢骨密度
 - D. 做血液培養並給抗生素
 - E. Tc 99 m骨頭掃描
- (C) 3. 56歲男性10個月前被發現糖尿病，飯前151 mg/dl，飯後289 mg/dl，血壓 170/99 mmHg，BMI 27 kg/M²，CHO 210 mg/dl，TG 287 mg/dl，HbA1c 7.4%，給予ACEI，metformin、glipizide 及飲食治療，3個月後，HbA1c 8.3%，BMI 26 kg/M²，經藥物調整後血壓已正常，但HbA1c 9.1%，目前他使用metformin 1000 mg b.i.d.，rosuvastatin 10 mg qd，來診抽血檢查 TSH 1.2uU/ml，HbA1c 9.5%，CHO 302 mg/dl，HDL 37 mg/dl，LDL 140 mg/dl，TG 803 mg/dl。你建議用那一藥物來治療？
- A. Niacin
 - B. Pioglitazone
 - C. Insulin
 - D. Fenofibrate
 - E. Ezetimibe
- (B) 4. 35歲女性因斷斷續續發生低血糖症狀已有1年來診，最近一星期前意識不清被送急診，血糖為39 mg/dl。在門診空腹抽血檢查 AC 61 mg/dl，insulin 4uU/ml，C-peptide 0.9 ng/ml，cortisol 16 ug/dl，IGF-1 300 ng/ml，TSH 1.2uU/ml，最恰當處置為：
- A. 腹部電腦斷層
 - B. 住院做72 hour fasting test
 - C. 口服葡萄糖耐性試驗
 - D. 轉介外科手術
 - E. Selective arterial calcium stimulation test

- (A) 5. 81歲男性有糖尿病史，只使用飲食控制，相關疾病有CAD、CHF、高血壓，他被送來急診因意識不清有24小時，體檢BP 96/74 mmHg，PR 104/min，one touch 血糖 > 500 mg/dl，抽血檢查血糖800 mg/dl，Na 150 mEq/L，K 6.1 mEq/L，BUN 80 mg/dl，Cr 3.5 mg/dl，動脈血PH 7.32，PCO₂ 33mm Hg，PO₂ 78 mmHg，Bicarbonate 19 meq/L，下列輸液何者為佳？
- A. Normal saline I.V.
 - B. Half saline I.V.
 - C. Lactate Ringer I.V.
 - D. N/G distilled water
 - E. 5% glucose water + Regular insulin IV
- (C) 6. 65歲男性因肺炎住院，在門診他因糖尿病服用Amaryl 3mg b.i.d，metformin 850 mg b.i.d，高血脂服用Lipitor 20 mg qd，高血壓服用Aprovel 150 mg qd，身體檢查稍有氣喘，血壓98/66 mmHg，體重 80KG，胸部X光左側肺炎，其他無特別發現。抽血檢查Random glucose 276 mg/dl，Na 132 mEq/L，K 3.8 mEq/L，Cr 1.7 mg/dl，WBC 18600/uL，HbA1c 一個月前在門診為8.3%，請問下列那一處置較恰當？
- A. 加Lactus 16 u hs.
 - B. 加Pioglitazone
 - C. 停用Metformin及Amaryl，用Lactus 16 U hs及每餐前RI（約略共16 U）
 - D. 停用Metformin及Amaryl，全部用RI sliding scale控制血糖
 - E. 停用Metformin，加上sliding scale regular insulin（血糖 > 150 mg/dl）
- (D) 7. 65歲男性因慢性淋巴球白血病接受化療，住院中發現糖尿病，血糖介於230-280 mg/dl，BMI 19.5 kg/M²，體檢發現脾腫大，Gr 2/6 收縮心雜音及壓下性腳水腫，抽血檢查血紅素8 gm/dl，HbA1c 6.3%，WBC 18600/uL，Albmin 2.9 g/dl，Cr 1.0 mg/dl，AC 178 mg/dl。下列敘述何者最恰當？
- A. 若飲食、運動無法於1個月內改善，便開始使用降血糖藥物
 - B. HbA1c尚在正常範圍，暫不須治療
 - C. 高血糖是實驗室失誤引起
 - D. HbA1c因貧血而不準確
 - E. HbA1c因白血球增加而不準確
- (C) 8. 口服降血糖藥物Pioglitazone使用之禁忌為？(1) 高血壓 (2) 腎衰竭第三期 (3) 心衰竭第三期 (4) 肝功能異常 (5) 肥胖
- A. (1)+(2)
 - B. (2)+(3)
 - C. (3)+(4)
 - D. (4)+(5)

E. (1)+(5)

- (E) 9. 有關第2型糖尿病之治療原則，除生活型態、飲食治療外，下列敘述何者正確？(1) Metformin是大部分病人的第一線用藥。(2) Sulfonylurea是對心血管疾病病人之禁忌。(3) DDP-4抑制劑對心臟有益可使用於心衰竭第三期病人(4) 糖化血色素達到7%以下為必要達成之目標。(5) Pioglitazone是Non-insulin dependent降血糖藥物

A. (1)+(2)
B. (2)+(3)
C. (3)+(4)
D. (4)+(5)
E. (1)+(5)

- (B) 10. 根據台灣糖尿病學會2012糖尿病照護指引應個別化考量血糖控制目標的因素有：(1) 體重 (2) 多重小血管病變 (3) 認知功能不足 (4) 癌症末期 (5) 社經地位

A. (1)+(2)+(3)
B. (2)+(3)+(4)
C. (3)+(4)+(5)
D. (1)+(4)+(5)
E. (1)+(2)+(5)

< 一〇四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 風濕科

- (C) 1. 一位65歲硬皮症女性病人，長期以免疫抑制劑控制病情，最近開始感覺走路會呼吸困難及疲倦，醫師懷疑有肺動脈高血壓，下列檢查是診斷肺動脈高壓之常用方法？(1)胸部X光 (Chest X-ray)；(2)右心導管檢查 (R't Heart Catheterization)；(3)左心導管檢查 (L't Heart Catheterization)；(4)抗核抗體 (ANA)；(5)超音波檢查 (Echocardiography)
- A. (1)+(2)+(3)
B. (1)+(3)+(4)
C. (1)+(2)+(5)
D. (1)+(4)+(5)
E. (3)+(4)+(5)
- (E) 2. 一位28歲男性主訴發燒、頭痛、腹瀉及皮膚紅疹有兩週，病人二個月前到孟加拉經商一週，曾有水狀腹瀉多天，下列檢查較不具診斷價值？
- A. 血液培養
B. 骨髓培養
C. 未經治療病人，感染一週之大便培養
D. 未經治療病人，感染三週之大便培養
E. Widal test
- (C) 3. 下列關節炎常需做關節腔液檢查(Synovial fluid analysis)以確定診斷
- A. 類風濕性關節炎 (RA)
B. 紅斑性狼瘡 (SLE)
C. 感染性關節炎 (septic arthritis)
D. 退化性關節炎 (OA)
E. 纖維肌痛症 (fibromyalgia)
- (B) 4. 下列疾病常以單一關節炎表現？(1) 退化性關節炎；(2)痛風關節炎；(3)類風濕性關節炎；(4)細菌感染性關節炎；(5)全身性紅斑性狼瘡
- A. (1)+(2)+(3)
B. (1)+(2)+(4)
C. (2)+(3)+(4)
D. (2)+(4)+(5)
E. (3)+(4)+(5)
- (B) 5. 下列何種抗體與新生兒狼瘡 (Neonatal lupus)合併先天性紅斑及先天性心臟傳導障礙有關？
- A. La抗體 (anti-La)
B. Ro抗體 (anti-Ro)
C. Scl-70抗體 (anti-Scl-70)
D. U1 RNP (anti-U1 RNP)

E. Sm抗體 (anti-Sm)

- (C) 6. 有關僵直性脊椎炎之相關基因，下列何者較不相關？
- A. HLA-B27
 - B. HLA-B61
 - C. DR4
 - D. ERAP-1
 - E. IL23R
- (D) 7. 40歲男性，反覆發生踝關節炎，常併有口腔潰瘍及尿道炎，偶有跟腱腫痛，血中ESR=30 hr/min, HLA-B27 negative, Rheumatoid factor: negative，下列何種疾病是最可能的診斷：
- A. 痛風
 - B. 紅斑性狼瘡
 - C. 類風濕性關節炎 (rheumatoid arthritis)
 - D. 脊椎關節炎 (spondyloarthritis)
 - E. 骨關節炎 (osteoarthritis)
- (C) 8. 38歲男性，有發炎性下背痛約半年，ESR=30 mm/1hr，但X-ray無明顯Sacroiliitis，下列診斷步驟何者不合理？
- A. 詢問有無脊椎關節炎家族史
 - B. 理學檢查
 - C. 核醫骨骼掃描 (Bone Scan)
 - D. 抽血測HLA-B27
 - E. 考慮SI joints MRI
- (E) 9. 發炎性下背痛 (Inflammatory low back pain)的特徵，下列何者為非？
- A. 發病年齡小於40
 - B. 漸進發生
 - C. 運動過後可減輕
 - D. 晨間僵硬
 - E. 血中RF陰性
- (D) 10. 下列哪些不是屬於抗吸收的 (anti-resorptive)抗骨質疏鬆藥物
- A. selective estrogen receptor modulator (raloxifene)
 - B. bisphosphonate
 - C. RANKL inhibitor (Denosumab)
 - D. parathyroid hormone (teriparatide)
 - E. hormone replacement therapy

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 免疫科

- (B) 1. 下列有關specific autoantibody與自體免疫疾病的配對中，何者最正確？
- A. Anti-collagen type II--Goodpasture's syndrome
 - B. Anti-aminoacyl-tRNA histidyl synthetase--Myositis
 - C. Anti-thyroid peroxidase--Graves' disease
 - D. Anti-myeloperoxidase--Granulomatosis with polyangiitis
 - E. Anti-keratin--SLE
- (A) 2. 一位23歲女性，從5歲開始皮膚持續發癢至今。就診時臉部、頸部、背部、腹部及四肢皮膚已呈苔癬化(lichenification)。請問對本患者最有用的檢查項目為：
- A. Serum specific IgE
 - B. Dermatography
 - C. Total eosinophil count
 - D. Serum complement C1 inhibitor levels
 - E. Skin pathology
- (E) 3. 一位26歲的SLE患者過去曾有3次流產紀錄，請問與下列的何種自體抗體最有相關？
- A. Anti-dsDNA
 - B. Anti-SSA/Ro
 - C. Anti-Sm
 - D. Anti-histone
 - E. Anti-phospholipid
- (C) 4. 41歲的女性來院求診的主訴為手、腳多處關節痠痛有三年之久。最近二個月來發現左手第2、3指的近端指間關節腫脹。在診所抽血檢查發現：ESR 32 mm/h、CRP 1.8 mg/dL、C3 89 mg/dL及C4 17.1 mg/dL，請問下列的何種檢查，對診斷類風濕性關節炎最有幫助？
- A. Rheumatoid factors
 - B. ANAs
 - C. Anti-CCP antibodies
 - D. Bilateral hand X-ray examination
 - E. Bilateral hand sonographic examination
- (E) 5. 48歲女性發現近三年來兩側手指在冬天會變白及變紫，經保暖之後會恢復。最近覺得吞嚥有點困難，及發現雙側手指的皮膚變厚、變硬。請問下列的何種檢查對診斷systemic sclerosis最有幫忙？
- A. Anti-U1RNP
 - B. Nailfold capillaroscopy
 - C. Pulmonary function test + DLCO
 - D. Anti-centromere antibody

E. Anti-topoisomerase-1

- (D) 6. 68歲的男性患者在15年前因兩手肘及頭皮皮膚病變，被皮膚科醫師診斷為"乾癬"，經治療之後皮膚症狀穩定。最近一個月來發現兩手多指的遠端指間關節腫脹疼痛。而且有多根手指變成"香腸指樣"(sausage-like finger)。抽血檢查發現ESR 48 mm/1h、CRP 3.8 mg/dL、Rheumatoid factor 14.3 IU/ml (normal < 10 IU/ml)、uric acid 8.1 mg/dL，X-光檢查發現手部遠端指間關節有破壞變型。因另有腰部痠痛經pelvic X-ray檢查發現S-I關節有明顯發炎反應，請問最有可能的診斷為：
- A. Rheumatoid arthritis
 - B. Gouty arthritis
 - C. Osteoarthritis
 - D. Psoriatic arthropathy
 - E. Ankylosing spondylitis
- (B) 7. 下列有關治療風濕病/自體免疫疾病的藥物與其副作用的配對中，在臨床上何者最為嚴重？
- A. Glucocorticoids--leukocytosis
 - B. Azathioprine--neutropenia
 - C. Methotrexate--oral mucosal ulcer
 - D. Intravenous cyclophosphamide pulse therapy--teratogenicity
 - E. Hydroxychloroquine--retinal detachment
- (C) 8. Rheumatoid arthritis的關節外的臨床表徵很多，下列的何種組合最為正確？(1) keratoconjunctivitis sicca (2) iritis/uveitis (3) periodontitis (4) cerebral vasculitis (5) 頸椎C1-C2 subluxation (6) pleuritis (7) renal tubular acidosis (8) cutaneous vasculitis (9) thrombocytopenia (10) intestinal mucositis
- A. (1)+(4)+(7)
 - B. (4)+(6)+(7)
 - C. (1)+(5)+(6)
 - D. (3)+(5)+(7)
 - E. (2)+(9)+(10)
- (D) 9. 血管炎症候群(vasculitis syndrome)的標幟抗體為ANCA，請問下列那些血管炎是ANCA(+) vasculitis？(1) drug-induced vasculitis (2) granulomatosis with polyangiitis (3) cancer-associated vasculitis (4) Churg-Strauss syndrome (5) Behcet's disease (6) microscopic polyangiitis (7) Kawasaki disease (8) idiopathic crescentic glomerulonephritis (9) giant cell arteritis (10) polyarteritis nodosa
- A. (1)+(3)+(5)+(7)
 - B. (1)+(2)+(3)+(4)

- C. (2)+(5)+(6)+(7)
- D. (2)+(4)+(6)+(8)
- E. (3)+(8)+(9)+(10)

- (B) 10. Chronic polyarthritis可以包括下列何種疾病？(1) gouty arthritis (2) rheumatoid arthritis (3) pyogenic arthritis (4) calcium pyrophosphate deposition disease (5) osteoarthritis (6) Lyme arthritis (7) pigmented villonodular synovitis (8) reactive arthritis (9) hemophilic hemarthrosis (10) sarcoidosis
- A. (1)+(2)+(3)
 - B. (2)+(5)+(10)
 - C. (3)+(5)+(9)
 - D. (4)+(6)+(8)
 - E. (5)+(7)+(8)

< —○四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 血液科

- (B) 1. 一位35歲女性，無特殊病史，五年前的體檢顯示血液相為正常。最近感覺爬坡時會有呼吸急促的現象；身體檢查顯示血壓為126/82 mmHg，脈搏規則，每分鐘92下，臉色蒼白，無其他異常；血液檢查顯示Hb 8.4 g/dL，MCV 69fL，白血球及血小板無異常。此病人貧血最可能的原因為
- A. 海洋性貧血 (Thalassemia)
 - B. 缺鐵性貧血 (Iron deficiency anemia)
 - C. 慢性炎症反應引發之貧血 (Anemia of chronic inflammation)
 - D. 甲狀腺疾病
 - E. 腎臟病
- (A) 2. 一位27歲男性患有免疫性血小板低下性紫斑症(ITP)，對於傳統治療如prednisolone, azathioprine等的效果不佳，醫師建議他切除脾臟。在手術前下列何種藥物治療是最適當的選擇？
- A. Eltrombopag
 - B. GM-CSF
 - C. Desmopressin
 - D. High dose dexamethasone
 - E. Tranexamic acid
- (C) 3. 下列疾病何者引發血栓(thromboembolism)的可能性最小？
- A. Antiphospholipid antibody syndrome
 - B. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
 - C. Hereditary spherocytosis
 - D. Myeloproliferative neoplasm
 - E. Ovarian cancer
- (A) 4. 急性骨髓性白血病的病人，帶有下列何種染色體或基因變異預後最差？
- A. -7
 - B. t(8;21)
 - C. inv(16)
 - D. CEBPA mutation
 - E. NPM1 mutation
- (D) 5. 下列各惡性血液疾病與標靶治療的配對，何者有誤？
- A. Diffuse large B-cell lymphoma : rituximab
 - B. Acute promyelocytic leukemia : arsenic trioxide
 - C. Multiple myeloma : bortezomib
 - D. Myelofibrosis : azacitidine
 - E. Acute lymphoblastic leukemia with t(9;22) : imatinib

- (D) 6. 一位19歲病患，因發燒不退來到急診處。身體檢查顯示喉嚨發紅，無出血傾向，無呼吸急促；抽血檢查發現血紅素 8.1 g/dL，紅血球 2,710,000/uL，網狀紅血球 0.5%；白血球 1,200/uL，其中neutrophils 15%，lymphocytes 80%，monocytes 4.5%，eosinophils 0.5%；血小板 18,000/uL；骨髓檢查証實為再生不良性貧血。以下處置，何者最不需要？
- A. Search for HLA-matched sibling donor
 - B. Blood culture
 - C. Chest X-ray
 - D. Platelet concentrate transfusion
 - E. Antibiotics treatment
- (B) 7. 一位38歲病患，健康檢查時發現白血球數目增高，血液抹片如圖所示，此病人白血球增高最可能的原因為何？
- A. 急性骨髓性白血病
 - B. 慢性骨髓性白血病
 - C. 急性淋巴芽細胞白血病
 - D. 慢性淋巴芽細胞白血病
 - E. 反應性白血球增生
- (E) 8. 類血友病(von Willebrand disease)的發生率較血友病高，這種病人大多會出現下列何種檢驗異常？(1) 血小板功能異常 (2) PT延常 (3) aPTT延常 (4) Factor VIII濃度下降
- A. (3)
 - B. (2)+(3)
 - C. (1)+(3)
 - D. (3)+(4)
 - E. (1)+(3)+(4)
- (C) 9. 多發性骨髓瘤的國際分期系統(International staging system)，是根據下列那些指標？(1) 白蛋白的濃度 (2) 免疫球蛋白的濃度 (3) β 2-microglobulin (4) 血紅素
- A. (1)+(2)
 - B. (2)+(3)
 - C. (1)+(3)
 - D. (1)+(3)+(4)
 - E. (2)+(3)+(4)
- (C) 10. 腫瘤溶解症候群(Tumor lysis syndrome)常發生在生長快速的腫瘤，尤其是對化學治療很敏感的惡性病，以下何者為常見的檢驗異常？(1) Hyperkalemia (2) Hyperphosphatemia (3) Hyperuricemia (4) Hypercalcemia
- A. (1)+(3)
 - B. (2)+(3)
 - C. (1)+(2)+(3)
 - D. (1)+(3)+(4)

E. $(1)+(2)+(3)+(4)$

< 一〇四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 腫瘤科

- (D) 1. 下列何組腫瘤標記(tumor markers)與特定癌症的配對最為合宜? 當該癌症治療期間, 可檢測該腫瘤標記, 做為評估腫瘤總量(tumor burden)的輔助判斷參考。
- A. CA-125與Colon cancer
 - B. CD30與Hairy cell leukemia
 - C. CA-153與Gestational trophoblastic disease
 - D. Calcitonin與Medullary cancer of the thyroid
 - E. Neuron-specific enolase (NSE)與Non-small cell carcinoma of the lung
- (D) 2. 一位63歲男性病人, 因聲音沙啞(hoarseness)約3個月而就醫, 他過去25年平均每天抽菸一包, 初步理學檢查頭頸部大致正常, 沒有頸部淋巴結腫大, 耳鼻喉鏡檢發現一喉部(laryngeal)病灶, 切片檢查證實鱗狀上皮細胞癌(squamous cell carcinoma), CT電腦斷層掃描顯示主要病灶最長徑約2.2公分, 正子掃描(FDG-PET)並沒有發現懷疑的淋巴結轉移。建議此病人最合適的治療方式為何?
- A. 化學治療
 - B. 手術切除併用根治性頸部淋巴結廓清術
 - C. 手術切除併用根治性頸部淋巴結廓清術, 術後再用同步化療放射治療
 - D. 放射線治療
 - E. 緩和安寧(Hospice)治療
- (D) 3. 一位58歲男性病人, 以上腔靜脈症候群(SVC syndrome)為最初表現而至急診就醫, 被診斷罹患小細胞肺癌(small cell lung cancer, SCLC)。為進一步完整的癌症分期, 需再安排哪些檢查?
- A. 胸腔與腹腔CT電腦斷層掃描檢查
 - B. 腦部電腦斷層掃描CT, 或腦部磁共振造影掃描MRI檢查(加上靜脈顯影劑注射)
 - C. 骨髓切片(Bone marrow biopsy)檢查
 - D. A + B
 - E. A + B + C
- (E) 4. 一位41歲女性病人, 經病理切片確診罹患了第二期的子宮頸鱗狀上皮細胞癌(squamous cell carcinoma), 她先接受了腹式全子宮切除術, 加上雙側輸卵管與卵巢摘除術, 與骨盆腔淋巴結採樣。手術後病理檢查報告顯示腫瘤最長徑3.3公分, 並合併多個高危險病理結果陽性(包括deep stromal invasion, lymphovascular invasion, 4個淋巴結腫瘤陽性)。建議下一步最適宜的治療計畫為何?
- A. 已充分手術, 僅需定期追蹤觀察即可。至少每3-4個月追蹤骨盆腔理學檢查, 與系列CT電腦斷層掃描
 - B. 血清Human papilloma virus (HPV) 檢查
 - C. 手術後骨盆腔放射線治療

- D. 手術後化學治療
- E. 手術後骨盆腔放射線治療，合併同步化學治療

- (A) 5. 下列女性，何者可能有「最低」的乳癌罹患風險？
- A. 一女性初經(menarche)在16歲，第一胎懷孕生產在18歲，之後停經(menopause)在44歲
 - B. 一女性初經(menarche)在14歲，第一胎懷孕生產在18歲，之後停經(menopause)在52歲
 - C. 一女性初經(menarche)在12歲，第一胎懷孕生產在24歲，之後停經(menopause)在48歲
 - D. 一女性初經(menarche)在16歲，第一胎懷孕生產在32歲，之後停經(menopause)在52歲
 - E. 以上女性，罹患乳癌的風險均相同
- (C) 6. 一位68歲男性病人，因約一個月的無痛性黃疸(painless jaundice)逐漸惡化而就醫，合併有約3公斤體重減輕，理學檢查無明顯其他異常。進行dual-phase顯影CT電腦斷層掃描，發現胰臟頭部有一疑似腫塊，合併膽管擴張。要進一步證實確診「胰臟癌」，建議最適宜的檢查診斷方式為何？
- A. 內視鏡逆行膽胰管攝影(ERCP)合併胰液採樣，以進行細胞學檢查(cytology)
 - B. CT電腦斷層掃描導引下，經皮膚(percutaneous)進行needle biopsy切片病理檢查
 - C. 內視鏡超音波(endoscopic ultrasound, EUS)導引下，進行needle biopsy切片病理檢查
 - D. FDG-PET 正子掃描攝影
 - E. 抽血檢查血清CA19-9數值
- (D) 7. 有一21歲男性病人，約一個月前因右小腿脛骨前側腫痛而就醫，先前並無碰撞受傷的病史。右下肢X光顯示骨骼似蟲蛀樣(moth-eaten)破壞，且延伸至骨周圍的軟組織，並有針樣的骨周圍反應(periosteal reaction)，軟組織腫塊和骨周圍反應，結合形成Codman氏三角(Codman's triangle)徵象。醫師判斷最可能的診斷，與建議何種最合適的治療計畫？
- A. 漿細胞腫瘤(plasma cell tumor, plasmacytoma)；化學治療
 - B. 惡性軟骨肉瘤(chondrosarcoma)；化學治療
 - C. 惡性軟骨肉瘤(chondrosarcoma)；放射線治療合併局部切除手術
 - D. 惡性骨肉瘤(osteosarcoma)；手術前化學治療，之後進行肢體保全(limb-sparing)手術
 - E. 惡性骨肉瘤(osteosarcoma)；放射線療法
- (D) 8. 以下哪些病症或症候群，會增加患者罹患癌症的風險？(1) Fanconi's anemia (2) Down syndrome (3) Von Hippel-Lindau syndrome (4) Fragile X syndrome (5) Neurofibromatosis

- A. (1)+(2)+(4)
- B. (2)+(3)+(4)
- C. (1)+(3)+(4)+(5)
- D. (1)+(2)+(3)+(5)
- E. (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(B) 9. 癌症的標靶治療(targeted therapy)藥劑，通常針對特定的訊息傳遞路徑或分子標靶進行抑制，以達到治療癌症的目的。下列治療藥劑與分子標靶(molecular target)的配對，哪些正確? (1) Erlotinib 與 EGFR (2) Ipilimumab 與 CTLA-4 (3) Imatinib 與 Bcr-Abl (4) Vemurafenib 與 B-Raf (5) Rituximab 與 CD30

- A. (1)+(2)+(3)+(5)
- B. (1)+(2)+(3)+(4)
- C. (2)+(3)+(4)+(5)
- D. (3)+(4)+(5)
- E. (2)+(4)+(5)

(D) 10. 一位70歲男性病人，因近2個月右側腰痛，合併近1個月血尿(hematuria)逐漸加重而就醫。三星期前，在門診初診斷為膀胱炎先進行治療，但症狀並未改善，且病人合併食慾不振與體重減輕約4公斤。理學檢查發現右側腰部有一可觸診的腫塊約10公分，腎功能檢查目前仍屬正常。以下有關此病人的可能診斷，那些正確? (1) 超過半數的病理診斷，多屬亮細胞上皮癌(clear cell carcinoma) (2) 抽菸為已知的相關危險因子之一 (3) 貧血(anemia)較紅血球增多症(erythrocytosis)常見 (4) 第一期或第二期的此種癌症，經根治性手術切除後，5年整體存活率超過80% (5) 第四期轉移性的此種癌症，經由各種標靶治療(targeted therapy)藥劑的進展，5年整體存活率已可超過50%

- A. (1)+(3)+(5)
- B. (3)+(4)+(5)
- C. (1)+(2)+(3)+(5)
- D. (1)+(2)+(3)+(4)
- E. (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 神經科

- (B) 1. 20歲女性因左手無力就診，神經學檢查顯示左側的手指無法完全張開與閉合，掌骨間肌 (interossei muscle) 無力萎縮，是那一條神經受損？
- A. 正中神經 (median nerve)
 - B. 尺神經 (ulnar nerve)
 - C. 橈神經 (radial nerve)
 - D. 肌表皮神經 (musculocutaneous nerve)
 - E. 長胸神經 (long thoracic nerve)
- (E) 2. 25歲女性有紅斑性狼瘡 (systemic lupus erythematosus) 合併腎炎有3年，使用類固醇、免疫抑制劑 (cyclophosphamide)，因意識不清與癲癇至急診，理學檢查血壓200/110 mmHg、體溫37°C，脊髓液檢查顯示無白血球、蛋白濃度稍增加，腦部磁共振顯示兩側枕葉有不正常訊號，最可能的診斷為何？
- A. 腦膜腦炎 (meningoencephalitis)
 - B. 尿毒腦病變 (uremic encephalopathy)
 - C. 急性去髓鞘腦炎 (acute demyelinating encephalitis)
 - D. 急性腦梗塞 (acute cerebral infarction)
 - E. 可逆性後腦病變症候群 (posterior reversible encephalopathy syndrome)
- (E) 3. 25歲女性，因突然複視與右側肢體無力就診，之前有心雜音、最近3個月有輕度發燒、倦怠、體重減輕5公斤，檢查時須注意哪些徵候？(1) Gottron's sign；(2) Janeway's lesion；(3) Heliotrope sign；(4) Roth's spot。
- A. (1)+(2)
 - B. (2)+(3)
 - C. (3)+(4)
 - D. (4)+(1)
 - E. (2)+(4)
- (A) 4. 55歲女性因風濕性心臟病、瓣膜置換與心房顫動，使用口服抗凝劑，因腦出血至急診，INR為5.5，使用下列何種治療能最快恢復凝血功能？(1) Vitamin K；(2) Fresh frozen plasma；(3) Platelets；(4) Prothrombin complex concentrates；(5) Whole blood
- A. (1)+(2)
 - B. (1)+(2)+(3)
 - C. (1)+(2)+(4)
 - D. (1)+(3)+(5)
 - E. (1)+(4)+(5)
- (A) 5. 50歲女性罹患肌無力 (myasthenia gravis) 4年，因肺炎併發呼吸衰竭入住加護病房，下列那些類別的抗生素較不適合使用？(1) Quinolones；(2) Beta-lactam + beta-

lactamase inhibitor ; (3) Macrolides ; (4)
Cephalosporins 。

- A. (1)+(3)
- B. (2)+(4)
- C. (1)+(4)
- D. (2)+(3)
- E. (1)+(2)+(3)+(4)

(B) 6. 相較於肌無力 (myasthenia gravis) , 藍伯-伊頓肌無力症 (Lambert-Eaton myasthenic syndrome) 較常出現那些症狀? (1) 眼皮下垂、複視; (2) 肌腱反射下降; (3) 口齒不清及吞嚥困難; (4) 自律神經失調症狀, 如口乾、便秘、小便困難。

- A. (1)+(3)
- B. (2)+(4)
- C. (1)+(4)
- D. (2)+(3)
- E. (1)+(2)+(3)+(4)

(E) 7. 40歲女性因肢體顫抖就診, 腦部斷層掃描檢查顯示有明顯兩側基底核鈣化, 下列那些疾病須考慮? (1) 一氧化碳中毒 (carbon monoxide intoxication); (2) 粒線體疾病 (mitochondrial disease); (3) 腦囊尾幼蟲症 (neurocysticercosis); (4) 副甲狀腺低能症 (hypoparathyroidism) 。

- A. (1)+(3)
- B. (2)+(4)
- C. (1)+(4)
- D. (2)+(3)
- E. (1)+(2)+(3)+(4)

< 一〇四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 精神科

- (C) 1. 關於親人過世之後哀慟反應(grief)，下列何者錯誤？
- A. 有證據指出在哀慟反應的急性期心肌梗塞風險增加
 - B. 在哀慟反應的急性期血壓心跳會增加
 - C. 在哀慟反應的急性期血中cortisol濃度降低
 - D. 有2%到3%失去親人的民眾，哀慟反應持續太久，強度未隨時間減弱，呈現「複雜性」哀慟反應(complicated grief)
 - E. 複雜性哀慟反應需要跟重度憂鬱症(major depression)以及創傷後壓力症(posttraumatic stress disorder)作鑑別診斷
- (C) 2. 關於老年憂鬱症(depression in the elderly)下列何者錯誤？
- A. 罹患憂鬱症會增加個案罹患失智症的風險
 - B. 生活作息改變(lifestyle changes)也是治療方式之一
 - C. 以生活作息改變作為治療方式，通常可以單獨達到治療效果
 - D. 藥物治療與心理治療都可以考慮作為第一線的治療
 - E. 選擇性血清素再吸收抑制劑(selective serotonin reuptake inhibitor: SSRI)被建議當作藥物治療的首選
- (A) 3. 關於詐病(malingering)與庠病症(factitious disorder)下列何者為非？
- A. 具有「醫療無法解釋的身體症狀」(medically unexplained physical symptoms)的病患，都是有精神科診斷的
 - B. 處理庠病症個案的原則包括「顧全個案顏面」(face saving)以及「減低傷害」(harm minimization)
 - C. 除了醫療上詳盡的病史詢問與病歷資料回顧，確認詐病與庠病症也需要醫療以外的調查資訊(non-medical investigation)來支持診斷之確立
 - D. 僅依靠「臨床技術」(clinical skills)本身不足以偵測(detect)或診斷詐病
 - E. 即使有明確的神經科或精神科診斷的病患，他們的異常生病行為(abnormal illness behaviors)，也並非完全源自於他們罹患的疾病本身
- (D) 4. 關於老年人的譫妄(delirium)下列何者為非？
- A. 沒有足夠的證據證明投予藥物可以有效地「預防」譫妄發生
 - B. 在一般醫療情境(general medicine)當中，憂鬱症(depression)曾經被證明是譫妄的危險因子之一
 - C. Serum urea 增加也是譫妄的危險因子之一
 - D. 腦波檢查(electroencephalography: EEG)對於診斷譫妄，有良好的敏感度(sensitivity)及特異度(specificity)
 - E. Haloperidol 0.5mg BID 是合理的藥物治療選擇

- (E) 5. 下列合者非恐慌發作(panic attack)的典型症狀？
- A. 心悸 (palpitation)
 - B. 胸痛 (chest pain)
 - C. 害怕自己快要死掉 (fear of dying)
 - D. 異物梗塞感 (feeling of choking)
 - E. 易怒情緒 (irritable mood)
- (A) 6. 關於抗憂鬱藥物副作用的處理方式，下列合者為非？
- A. 噁心 (nausea)：持續很久且與劑量無關，可併用制酸劑幫助緩解或隨餐服用
 - B. 性高潮不能 (anorgasmia)：使用cypheptadine 4mg to 8mg 於性活動前2小時服用
 - C. 體重上升 (weight gain)：運動節食或考慮改為 fluoxetine
 - D. 姿勢性低血壓 (orthostatic hypotension)：不容易產生耐受性而自然緩解，增加飲水量，或是使用 fludrocortisone 0.025mg/day
 - E. 抗乙醯膽鹼(anticholinergic)副作用：等待耐受性產生 (wait for tolerance)
- (E) 7. 關於治療雙極性情感疾患(bipolar affective disorder)的情緒穩定劑(mood stabilizer)的特性，下列何者為是？(1) 鋰鹽(lithium)的有效血中治療濃度範圍為 8-12 meq/L；(2) Thiazide會減少鋰鹽的血中濃度；(3) Valproic acid的有效血中治療濃度為50-125 ug/ml；(4) 胰臟炎(pancreatitis)是 Valproic acid可能的罕見副作用之一；(5) Lamotrigine的罕見副作用包括Stevens-Johnson syndrome
- A. (1)+(2)+(3)
 - B. (1)+(3)+(5)
 - C. (2)+(3)+(4)
 - D. (1)+(2)+(5)
 - E. (3)+(4)+(5)

< —○四年度試題目錄 >

一〇四年度內科專科醫師考試筆試題 -- 皮膚科

- (C) 1. 30歲男性，皮膚病變如圖，以下何者為必需之處置？(1) 抽血檢查有無HIV感染；(2) 詢問性行為史；(3) 抽血檢查有無梅毒；(4) 切取組織作病理檢查
- A. (1)+(3)
B. (2)+(4)
C. (1)+(2)+(3)
D. (4)
E. (1)+(2)+(3)+(4)
- (A) 2. 一位50歲女性，發生如圖所示的皮疹。皮膚切片檢查發現有 acantholysis, keratinocytes necrosis 及 vacuolar-interface dermatitis。直接免疫螢光反應 (DIF) 發現IgG 及 complement 沈積於角質細胞表面及表皮基底膜。下列何者正確？(1)應做惡性腫瘤篩檢；(2)應詢問用藥史，並立刻停止目前使用之藥物；(3)應密切注意病患是否發生呼吸困難；(4)以高劑量類固醇治療，一般都會很有效。
- A. (1)+(3)
B. (1)+(2)+(4)
C. (1)+(2)+(3)
D. (3)+(4)
E. (1)+(2)+(3)+(4)
- (D) 3. 一58歲男性，皮膚劇癢及脫屑已有3年。近3個月以來，由斑塊變成全身發紅。皮膚劇癢至會干擾生活的程度。用藥方面只有近5年來使用lisinpril控制高血壓。身體檢查發現 vital sign 都正常。體表如圖所示90%皮膚都發紅並脫屑，而且有全身性淋巴結腫大，手掌角掌增厚，趾甲變厚。以下何者是最可能的診斷？
- A. Drug hypersensitivity reaction
B. Pustular psoriasis
C. Staphylococcal scalded skin syndrome
D. Cutaneous T-cell lymphoma
E. Atopic dermatitis
- (C) 4. 一68歲男性，有長期糖尿病病史，3年兩側下肢感覺異常，兩年勃起障礙。腳底發生如圖所示不痛的潰瘍已有6個月。BMI 32。他不抽煙，腳底未受傷過，無跛行 (claudication)，無夜間足部疼痛。足部檢查，顯示 dorsalis pedis 脈動變小，腳踝並無色素沈澱。最可能的診斷是什麼？
- A. Venous stasis ulcer
B. Vasculitic ulcer
C. Neuropathic ulcer
D. Ischemic ulcer
E. Clavus

- (A) 5. 一病人因leukocytoclastic vasculitis, 使用dapsone治療25天後產生fever, lymphadenopathy, 及如圖所示皮疹, 但無mucosa ulcer。請問為確定診斷, 以下最應立即做的兩項檢查是什麼?
- A. CBC (包括differential count) 及Liver function test
 - B. Lymph node biopsy及skin biopsy
 - C. Blood bacterial culture 及fungal culture
 - D. MAST 及prick test檢測過敏原
 - E. Patch test
- (A) 6. 一位64歲男性因三天以來快速蔓延的全身發紅、疼痛及融合的膿疱至急診就診。當時體溫為38.9 C。詢問病史, 瞭解他有輕微尋常性乾癬及氣喘。尋常性乾癬用外用藥控制得不錯。他因氣喘服用了十天類固醇至一星期前才停藥。請問最可能的診斷是什麼?
- A. Pustular psoriasis
 - B. Acute generalized exanthematous pustulosis
 - C. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms
 - D. Sweet syndrome
 - E. Candida albicans infection
- (C) 7. 一女性病患全身及臉部發生如圖所示皮膚變化已有二年, 以下何種檢查對此病人最為有用?
- A. Liver function
 - B. Renal function
 - C. Thyroid function
 - D. Pulmonary function
 - E. Muscle power test